



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**"Ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής εφήβων και νεαρών ενηλίκων με
καρκίνο και των οικείων τους: περιγραφική ανασκόπηση"**

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ -
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΩΝΙΔΑ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

Στην οικογένειά μου, τη Βάσια και τη Περσεφόνη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.....	6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	8
ABSTRACT.....	9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΜΕΛΕΤΗ.....	13
1.1 Ορισμός θέματος.....	13
1.2 Χρησιμότητα έρευνας	14
1.3 Δομή εργασίας.....	14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	15
2.1 Καρκίνος	15
2.1.1 Ορισμός και ιστορικά στοιχεία.....	15
2.1.2 Καρκίνος σε εφήβους και νέους ενήλικες	17
2.2 Ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής στον καρκίνο	19
2.2.1 ΑΥΑ ασθενείς.....	20
2.2.2 Οικείοι των ΑΥΑ ασθενών.....	22
2.3 Κοινωνική υποστήριξη.....	24
2.3.1 Ορισμός και βασικά στοιχεία	24
2.3.2. Κοινωνική υποστήριξη σε ΑΥΑ ασθενείς με καρκίνο.....	25
2.3.3 Κοινωνική υποστήριξη στους οικείους ΑΥΑ ασθενών με καρκίνο.....	26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.....	30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	32
5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.....	32
5.1.1 ΑΥΑ ασθενείς.....	32
5.1.2 Γονείς/φροντιστές ΑΥΑ ασθενών	35
5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	41
6.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.....	41
6.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.....	42
6.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.....	44
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	46

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η εν λόγω βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχεύει στη διερεύνηση της ψυχικής υγείας των εφήβων και νέων ενηλίκων με καρκίνο, καθώς και των οικείων/φροντιστών τους. Παράλληλα, διερευνάται και ο ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης στη ψυχική υγεία των ανωτέρω.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Για τη παρούσα μελέτη διενεργήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και βρέθηκαν διαφόρων τύπων έρευνες, όπως μετα-ανασκοπήσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις, διαχρονικές και συσχετιστικές μελέτες. Εντέλει, επιλέχθηκαν 10 μελέτες. Τα κριτήρια επιλογής των μελετών ήταν να έχουν δείγμα εφήβων και νέων ενηλίκων με καρκίνο (15-39 ετών) ή δείγμα παιδιών με καρκίνο, με μέσο όρο ηλικίας τα 11 έτη (δηλαδή την αρχή της εφηβείας). Επίσης, κριτήριο επιλογής ήταν να συμπεριλαμβάνεται κάποιος δείκτης ψυχικής υγείας των ασθενών. Κριτήριο αποκλεισμού ήταν το είδος της έρευνας, καθώς δε συμπερίλφθηκαν ποιοτικές έρευνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Φαίνεται ότι όσον αφορά τους ίδιους τους εφήβους και νέους ενήλικες ασθενείς η ψυχική υγεία ή και ποιότητα ζωής τους είναι επιβαρυνμένη σε σχέση με αυτή των υγιών συνομηλίκων τους. Η ίδια ξεκάθαρη εικόνα δεν υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον των εφήβων ασθενών, όπου τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Υπάρχουν, δηλαδή, έρευνες που βρίσκουν ίδια επίπεδα ψυχικής υγείας σε γονείς ασθενών, ενώ άλλες που υποστηρίζουν τη χειρότερη ψυχική υγεία τους. Παρ' όλα αυτά, όλες οι έρευνες υπογραμμίζουν το ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης σε ασθενείς και οικείους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μια χρονική περίοδο ευαλωτότητας για τους εφήβους με καρκίνο, στην οποία προκύπτουν αυξημένα συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και μετατραυματικού στρες. Εδώ όμως, η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται να εξομαλύνει τα συμπτώματα αυτά. Η ψυχική υγεία των οικείων των εφήβων ασθενών παρουσιάζει πιο σύνθετη εικόνα, η οποία εν πολλοίς σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που περνάει μετά τη διάγνωση. Παρ' όλα αυτά η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά και στο οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο.

Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος, έφηβοι, νέοι ενήλικες, ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής, κοινωνική υποστήριξη

ABSTRACT

OBJECTIVE: This literature review aims to investigate the mental health of adolescents and young adults with cancer and their family/caregivers. At the same time, the role of social support in their mental health is also explored.

METHODS: For this study, electronic databases were searched and various types of research were found, including meta-analyses, systematic reviews, longitudinal and correlational studies. In the end, 10 studies were selected. The selection criteria for the studies were to have a sample of adolescents and young adults with cancer (15-39 years old) or a sample of children with cancer, with a mean age of 11 years (i.e. early adolescence). In addition, a selection criterion was to include an indicator of patients' mental health. The exclusion criterion was the type of survey, as qualitative surveys were not included.

RESULTS: It appears that as far as the adolescent and young adult patients themselves are concerned, their mental health and/or quality of life is poorer than that of their healthy peers. The same clear picture does not exist in the family environment of adolescent patients, where the results are contradictory. That is, there are studies that find equal levels of mental health in parents of patients, while others support worse mental health. Nevertheless, all studies emphasise the role of social support to patients and family members.

CONCLUSIONS: The results demonstrate a period of vulnerability for adolescents with cancer, in which increased symptoms of anxiety, depression and post-traumatic stress arise. Here, however, social support appears to smooth these symptoms. The mental health of adolescent patients' family members presents a more complex picture, which is largely related to the length of time after diagnosis. Nevertheless, social support also seems to have a protective effect on the patients' family environment, in an indirect or direct way.

Key-words: cancer, adolescents, young adults, mental health, quality of life, social support

Γενικό μέρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αφορούν τις νέες διαγνώσεις και τους θανάτους, φαίνεται ότι ο καρκίνος αποτελεί τη μάστιγα της εποχής μας. Μόνο το 2024, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φαίνεται ότι στην Αμερική θα υπάρξουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις καρκίνου, ενώ 612 χιλιάδες ασθενείς θα χάσουν τη μάχη με το καρκίνο (*Common Cancer Sites - Cancer Stat Facts*, n.d.). Ο καρκίνος στην εφηβική και νεαρή ενήλικη ζωή, από την άλλη, φαίνεται να έχει ιδιαίτερα γνωρίσματα. Πρόσφατα στοιχεία μας δείχνουν ότι ο καρκίνος που εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας 15-39 ετών αφορά μόνο το 4.2% του συνόλου των νέων διαγνώσεων καρκίνου. Ενώ επί του συνόλου των θανάτων λόγω κάποιας μορφής καρκίνου, οι θάνατοι που αφορούν έφηβους και νέους ενήλικες είναι μόνο το 1.5% (*Cancer Among Adolescents and Young Adults (AYAs) - Cancer Stat Facts*, no date).

Ο καρκίνος, όμως ως μια πολύπλοκη και προκλητική κατάσταση, δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική υγεία, αλλά συνδέεται και με έντονα συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Η ψυχική υγεία είναι, επίσης, ένα μείζον θέμα που άπτεται τόσο στο πεδίο της ιατρικής, όσο και στο πεδίο της ψυχολογίας και κοινωνιολογίας. Το πλήθος των ψυχοπιεστικών γεγονότων που καλείται ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει έχει αυξηθεί. Πόλεμοι, φτώχεια, πανδημίες, χρόνιες ασθένειες είναι ένα δείγμα μόνο από τις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής. Η πανδημία του Covid 19 αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα της σημασίας της ψυχικής υγείας στη σήμερον ημέρα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, φαίνεται ότι η πανδημία πυροδότησε μια ραγδαία αύξηση του επιπολασμού άγχους και κατάθλιψης παγκοσμίως (World Health Organization: WHO, 2022). Το παραπάνω δεδομένο υπογραμμίζει τη ξεκάθαρη, αμφίδρομη σχέση μεταξύ σωματικών ασθενειών και ψυχικών διαταραχών. Δηλαδή, μια αναπνευστική νόσος αφήνει τα χνάρια της στη ψυχική υγεία της παγκόσμιας ανθρωπότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο καρκίνος ως μια χρόνια ασθένεια σχετίζεται τόσο με τη σωματική, αλλά και με τη ψυχική υγεία των ασθενών. Η διαφορά εδώ έγκειται στο ότι ο καρκίνος αποτελεί μια χρόνια ασθένεια που όμως είναι απειλητική για τη ζωή. Ο καρκίνος δεν είναι μία μοναδική ασθένεια αλλά μια ευρεία κατηγορία

νοσημάτων με διαφορετικές μορφές, συχνότητες εμφάνισης και θεραπείες. Η πρόγνωση και η ανταπόκριση στη θεραπεία ποικίλλουν, ακόμα και σε περιπτώσεις με παρόμοια μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, γεγονός που τον διαφοροποιεί από άλλες χρόνιες παθήσεις (Pizzoli *et al.*, 2019).

Όπως αναφέρεται και στο “National Cancer Institute”, την επίσημη ιστοσελίδα για τον καρκίνο στις Η.Π.Α., μία διάγνωση καρκίνου ιδιαίτερα σε κάποιον νέο ενήλικα, ενέχει συνήθως πολλές συναισθηματικές μεταπτώσεις. Ως εκ τούτου η ψυχική υγεία των εφήβων και νέων ενηλίκων με καρκίνο είναι συχνά ευάλωτη. Υπογραμμίζεται, έτσι, ότι όσο σημαντικό είναι για τους ασθενείς να μιλούν και να ενημερώνονται για τα σωματικά συμπτώματα και παρενέργειες της ασθένειας ή της φαρμακευτικής αγωγής, άλλο τόσο κρίσιμο είναι μιλούν για τη ψυχική τους κατάσταση, έτσι ώστε να τους παράσχεται η ενδεδειγμένη φροντίδα. Εδώ είναι και το κομβικό σημείο της κοινωνικής υποστήριξης από την οικογένεια, συνομηλίκους και ιατρικό προσωπικό (National Cancer Institute, 2023).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΜΕΛΕΤΗ

1.1 Ορισμός θέματος

Η διάγνωση ενός καρκίνου σε έφηβους και νέους ανήλικες, κάνει τα πράγματα ακόμα πιο σύνθετα. Οι έφηβοι και νέοι ενήλικες (Adolescents and Young Adults-AYAs) με καρκίνο είναι άτομα 15-39 ετών που έχουν διαγνωσθεί με κάποια μορφή καρκίνου. Η διάγνωση του καρκίνου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Δεδομένα υποστηρίζουν ότι το βίωμα του καρκίνου, αλλά και οι προκλήσεις που αφορούν τη συναισθηματική ευημερία των ασθενών, διαφέρουν ανάμεσα στους γηραιότερους και νεότερους ενήλικες, αλλά και τους εφήβους (Park and Rosenstein, 2015). Δηλαδή, η ευαλωτότητα και μεταβλητότητα της εφηβείας, σε συνδυασμό με τη διάγνωση ενός καρκίνου, δημιουργούν μία ιδιαίτερη συνθήκη, με ξεχωριστές, αναπτυξιακές ανάγκες για τους εφήβους στην αναδυόμενη ενηλικίωση (Kazak *et al.*, 2010).

Η χρόνια ασθένεια ενός παιδιού ή εφήβου είναι μία πρόκληση που εγκυμονεί κινδύνους και άγχος, απαιτεί προσαρμογές και αλλαγές, όχι μόνο για το ίδιο το άτομο-ασθενή, αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά του (Knecht, Hellmers and Metzinger, 2015). Έτσι και με μία νέα διάγνωση καρκίνου. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί συναισθηματικές προκλήσεις για το σύστημα της οικογένειας ως σύνολο, αλλά και για τους γονείς και τα αδέλφια των ασθενών, ξεχωριστά. Οι καθημερινές ανάγκες των εφήβων ασθενών με καρκίνο είναι εν πολλοίς απαιτητικές, δημιουργώντας ενδεχομένως αισθήματα ψυχολογικής επιβάρυνσης στους γονείς που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό. Ενώ, τα αδέλφια των ΑYA ασθενών με καρκίνο, δύναται να βιώνουν αισθήματα παραμέλησης. Σε πρόσφατη μελέτη των McDonald και συνεργατών (2015) φαίνεται ότι τα αδέλφια ΑYA ασθενών με καρκίνο, που βρίσκονται σε θεραπεία ή υποτροπή, δηλώνουν περισσότερες ανεκπλήρωτες ανάγκες από την οικογένεια και τους γύρω τους (McDonald *et al.*, 2015).

Τέλος, κοινωνική υποστήριξη αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη ζωή των ανθρώπων, υγιών και μη. Πόσο μάλλον στην εφηβεία, την ηλικία που οι γονείς καταρρίπτονται από το απυρόβλητο των απόλυτων προτύπων για τα παιδιά και στη θέση τους μπαίνουν οι συνομήλικοι. Έτσι, η κοινωνική υποστήριξη παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου, τόσο για τους ίδιους τους εφήβους ασθενείς,

αλλά και τους οικείους τους. Δύναται να δράσει θετικά ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των υποκειμένων (ασθενών και οικείων), παρέχοντας πληροφορίες, παροτρύνοντας για συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή και αυξάνοντας την ανθεκτικότητά τους.

1.2 Χρησιμότητα έρευνας

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει, μέσα από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής των έφηβων και νεαρών ενηλίκων με καρκίνο και των οικείων τους. Σημαντικός παράγοντας μελέτης στη σχέση του βιώματος του καρκίνου με τη ψυχική υγεία των ΑYA ασθενών, θα είναι η κοινωνική υποστήριξη. Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια να καταδειχθεί, εάν η κοινωνική υποστήριξη δρα ως ένας προστατευτικός παράγοντας στις αρνητικές συνέπειες του καρκίνου στους εφήβους και στους οικείους τους. Καθώς η ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζει αρκετά κενά στο ζήτημα των ΑYA ασθενών με καρκίνο θα αξιοποιηθούν κυρίως μελέτες που προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να είναι το έναυσμα για να καλυφθεί αυτό το κενό.

1.3 Δομή εργασίας

Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται σε δύο κύρια μέρη. Το γενικό μέρος που αφορά την περιγραφή του σκοπού/χρησιμότητας της έρευνας, καθώς και τον ορισμό των βασικών εννοιών που αυτή πραγματεύεται. Ειδικότερα, δομούνται οι όροι «καρκίνος», «ψυχική υγεία», «ποιότητα ζωής» και «κοινωνική υποστήριξη». Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύονται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα της έρευνας και η συζήτηση αυτών. Ακολουθούν, τέλος, τα συμπεράσματα της έρευνας, οι περιορισμοί καθώς και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1 Καρκίνος

2.1.1 Ορισμός και ιστορικά στοιχεία

Από την πιο πρώιμη ιστορία της ανθρωπότητας, ο καρκίνος αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες ιατρικές προκλήσεις, με καταγραφές για την ασθένεια να υπάρχουν ήδη από την αρχαιότητα. Μία από τις πρώτες γραπτές αναφορές στον καρκίνο εντοπίζεται στο Έντγουν Σμιθ Παπίρους, ένα αρχαίο αιγυπτιακό ιατρικό κείμενο που χρονολογείται γύρω στο 3000 π.Χ., και περιγράφει την περίπτωση ενός όγκου του μαστού, ο οποίος πιθανότατα αντιστοιχεί σε καρκίνο. Το Εμπέρ Παπίρους, ένα ακόμη σημαντικό αιγυπτιακό ιατρικό κείμενο που χρονολογείται γύρω στο 1500 π.Χ., αναφέρεται σε διάφορους τύπους όγκων, όπως αυτοί της επιδερμίδας, της μήτρας, του στομάχου και του ορθού. Στα κείμενα αυτά, ο καρκίνος θεωρείται μια ανίατη και επικίνδυνη ασθένεια, συχνά συνδεδεμένη με την «κατάρρα των θεών» (di Lonardo, Nasi and Pulciani, 2015).

Η πεποίθηση ότι ο καρκίνος προερχόταν από θεϊκή τιμωρία και προκαλούσε φόβο και απόγνωση, παρέμεινε βαθιά ριζωμένη ακόμη και κατά τη διάρκεια της αρχαίας ελληνικής περιόδου. Ωστόσο, ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.), ο πατέρας της ιατρικής, προσέφερε μία από τις πρώτες επιστημονικές θεωρίες για την κατανόηση της νόσου. Αντί να αποδίδει την αιτία του καρκίνου σε θεϊκή τιμωρία, ο Ιπποκράτης ανέπτυξε την ιδέα ότι η ασθένεια σχετίζεται με την ανισορροπία των «τεσσάρων χυμών» του σώματος — αίμα, φλέγμα, κίτρινη χολή και μαύρη χολή. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, όταν η μαύρη χολή υπερίσχυε σε κάποια περιοχή του σώματος, προκαλούσε την ανάπτυξη του καρκίνου (di Lonardo, Nasi and Pulciani, 2015).

Όπως συνεχίζει η Di Lonardo και συνεργάτες (2015), Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη "καρκίνωμα" (carcinoma), συγκρίνοντας την ασθένεια με ένα καβούρι (στα ελληνικά "Καρκίνος"), καθώς το καρκινικό εξόγκωμα προσκολλάται στους γύρω ιστούς, όπως το καβούρι πιάνει τα πράγματα με τα νύχια του. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε αυτή την αναλογία για να

περιγράφει τη συμπεριφορά του όγκου, που αναπτύσσεται με επεκτατική και συχνά επιθετική φύση. Η σύγκριση αυτή ήταν το πρώτο βήμα στην κατανόηση του καρκίνου ως μια ασθένεια που "εισβάλλει" και διαβρώνει τον υγιή ιστό. Ο Κέλσος (25 π.Χ. - 50 μ.Χ.), ένας από τους σημαντικότερους Ρωμαίους ιατρούς, μετέφρασε τη λέξη του Ιπποκράτη στο λατινικό "cancer", που σημαίνει καβούρι. Η λέξη "cancer" επιβίωσε στη λατινική γλώσσα και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα στην ιατρική για να αναφέρεται στους όγκους, διατηρώντας την αναλογία του καβουριού που "κολλάει" στους γύρω ιστούς. Ο Γαληνός (130 - 200 μ.Χ.), επίσης σημαντικός ιατρός της ρωμαϊκής εποχής, περιέγραψε τους όγκους χρησιμοποιώντας τον ελληνικό όρο "όγκος" (oncos), που σημαίνει «πρήξιμο» ή «πρησμένος όγκος». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ακόμη για να περιγράψει κάθε είδους όγκο ή διόγκωση του σώματος.

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η πρόοδος στη ιατρική έρευνα για τον καρκίνο ανακόπηκε από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις υπερφυσικές ερμηνείες της ασθένειας. Οι θρησκευτικές αντιλήψεις θεωρούσαν τον καρκίνο ως μία μορφή θείας τιμωρίας ή κακίας, και οι ασθένειες γενικά συνδέονταν με θρησκευτικές ή πνευματικές αιτίες. Αντί να εξετάζεται η βιολογική φύση του καρκίνου, πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι η ασθένεια ήταν μολυσματική, προκαλούμενη από υπερφυσικές δυνάμεις ή την «κακή επιρροή» κάποιου άλλου ατόμου. Αυτή η αντίληψη παρέμεινε αρκετά ισχυρή και εμπόδισε τη συστηματική επιστημονική έρευνα γύρω από τη φύση του καρκίνου για πολλές δεκαετίες.

Οι ιατροί και οι επιστήμονες της εποχής της Αναγέννησης και του πρώιμου μοντερνισμού άρχισαν να αμφισβητούν αυτές τις πεποιθήσεις και να στραφούν σε πιο ρεαλιστικές εξηγήσεις για τις ασθένειες. Η ανατομία και η παρατήρηση των ανθρώπινων σωμάτων, μαζί με τη χρήση της εμπειρικής έρευνας, έθεσαν τις βάσεις για τις μελλοντικές ιατρικές ανακαλύψεις, που οδήγησαν σε πιο σύγχρονες και επιστημονικές ερμηνείες του καρκίνου.

Στις μέρες μας και σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (2021), ο καρκίνος ορίζεται ως μια ασθένεια κατά την οποία ορισμένα κύτταρα αναπτύσσονται ραγδαία και εξαπλώνονται σε άλλα μέρη του σώματος. Η διαδικασία αυτή, δηλαδή η δημιουργία νέων κυττάρων, όπου και όταν χρειάζεται, συμβαίνει και φυσιολογικά στον οργανισμό και ονομάζεται κυτταρική διαίρεση. Η διαφορά είναι ότι στη περίπτωση του καρκίνου, πολλαπλασιάζονται τα κατεστραμμένα ή ανώμαλα κύτταρα του οργανισμού, σχηματίζοντας όγκους, οι οποίοι μπορεί να είναι καρκινικοί (δηλαδή κακοήθεις) ή μη

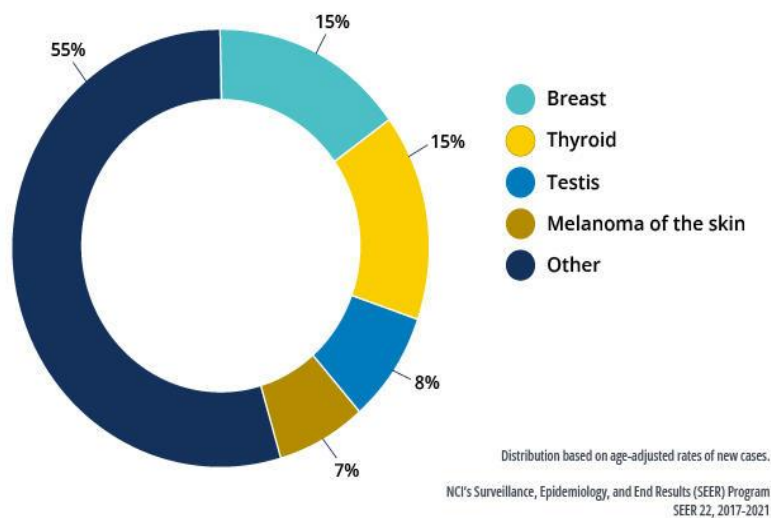
(καλοήθειες). Η διαφορά καλοηθών και κακοήθων όγκων είναι ότι οι δεύτεροι εξαπλώνονται στους γύρω ιστούς, κάνοντας μεταστάσεις, ενώ οι καλοήθειες όγκοι δεν εισβάλλουν στους γύρω ιστούς και συνήθως όταν αφαιρούνται δεν επανεμφανίζονται, σε αντίθεση με τους κακοήθεις που ακόμα και μετά την αφαίρεσή τους δύνανται να εμφανιστούν ξανά (National Cancer Institute, 2022).

Οι συχνότερες μορφές καρκίνου στους ενήλικες, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (National Cancer Institute, 2024), φαίνεται να είναι ο καρκίνος του μαστού με περίπου 311.000 νέες διαγνώσεις ετησίως σε γυναίκες και σχεδόν 2.800 σε άνδρες. Στη δεύτερη θέση έρχεται ο καρκίνος του προστάτη με σχεδόν 300.000 νέες διαγνώσεις ετησίως και ακολουθεί ο καρκίνος των πνευμόνων με σχεδόν 235.000 νέες διαγνώσεις ετησίως. Στην Ευρώπη ισχύουν περίπου τα ίδια δεδομένα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σε 40 Ευρωπαϊκές χώρες, η πρώτη σε νέες διαγνώσεις μορφή παραμένει ο καρκίνος του μαστού με 533.000 ετησίως, συνεχίζει ο καρκίνος του εντέρου με 520.000 ετησίως, των πνευμόνων με 480.000 ετησίως και του προστάτη με 470.000 νέες διαγνώσεις ετησίως (Dyba *et al.*, 2021).

2.1.2 Καρκίνος σε εφήβους και νέους ενήλικες

Στους εφήβους και νέους ενήλικες η εικόνα φαίνεται να αλλάζει. Σύμφωνα με τις προγνώσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ για το 2024, θα υπάρξουν περίπου 84.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου σε έφηβους και νέους ενήλικες, ποσό το οποίο αντικατοπτρίζει το 4.2% επί του συνόλου των νέων διαγνώσεων καρκίνου. Οι πιο συνήθεις τύποι καρκίνου στους ΑYA ασθενείς είναι: ο καρκίνος του μαστού και ο καρκίνος του θυροειδούς με 15% έκαστος επί του συνόλου των νέων διαγνώσεων σε ΑYA ασθενείς. Ακολουθεί ο καρκίνος των όρχεων με 8% επί του συνόλου και το μελάνωμα του δέρματος με ποσοστό 7%. Οι άλλοι τύποι για τους ΑYA ασθενείς συμπεριλαμβάνουν: τον καρκίνο του εγκεφάλου και άλλους όγκους του ΚΝΣ, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τη λευχαιμία, το λέμφωμα Χότζκιν και τα σαρκώματα που εμπεριέχουν τον καρκίνο των οστών και το σάρκωμα μαλακών μορίων (National Cancer Institute, 2023).

Common types of new cancers among AYAs



Διάγραμμα 1. Απεικόνιση των συνηθέστερων τύπων καρκίνου σε έφηβους και νέους ενήλικες (National Cancer Institute, 2024)

Πιο συγκεκριμένα και μέσα στην ομάδα των ΑYA ασθενών, οι συνηθέστερες μορφές καρκίνου είναι (National Cancer Institute, 2023):

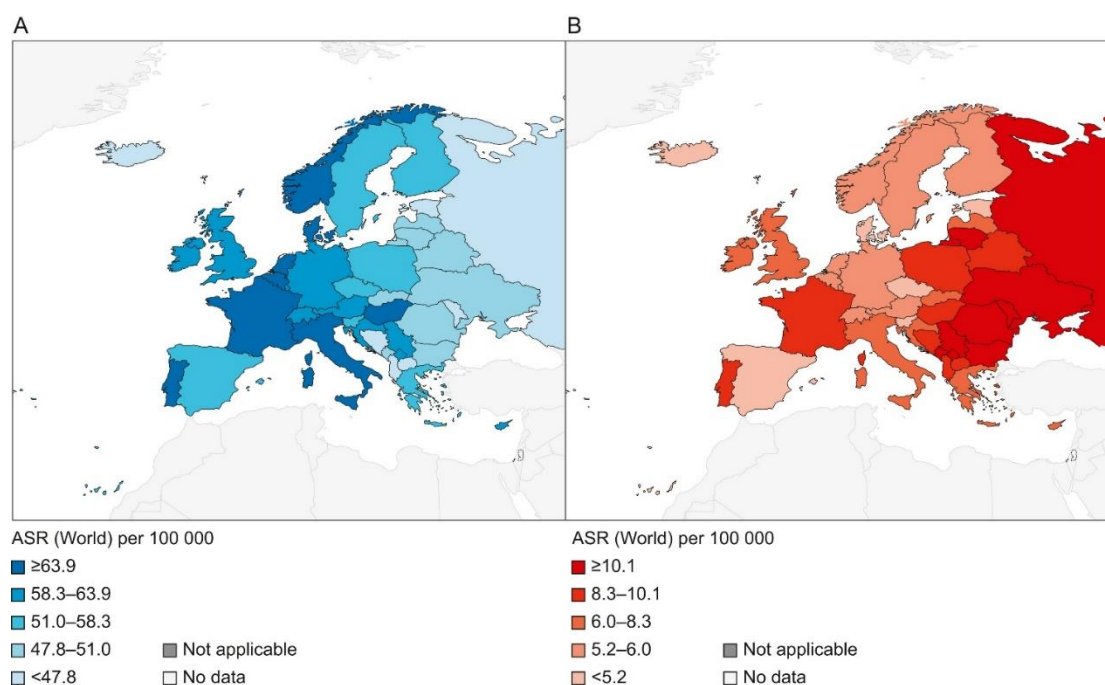
- Στους εφήβους 15-19 χρονών: ο καρκίνος του θυροειδούς, το λέμφωμα Χότζκιν, οι όγκοι του εγκεφάλου και άλλων μερών του ΚΝΣ και το λέμφωμα μη Χότζκιν
- Στους νέους ενήλικες 20-29 χρονών: ο καρκίνος του θυροειδούς, ο καρκίνος των όρχεων, το μελάνωμα και το λέμφωμα Χότζκιν
- Στους νέους ενήλικες 30-39 ετών: ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του θυροειδούς, το μελάνωμα και ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Τέλος, μια ακόμα διαφοροποίηση σχετίζεται με το φύλο των ΑYA ασθενών με καρκίνο. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι έφηβοι και άνδρες νέοι ενήλικες θα εμφανίσουν συχνότερα καρκίνο των όρχεων, καρκίνο του παχέος εντέρου, λέμφωμα μη Χότζκιν και καρκίνο του θυροειδούς. Ενώ, οι έφηβες και γυναίκες νέοι ενήλικες θα εμφανίσουν

συχνότερα καρκίνο του μαστού, καρκίνο του θυροειδούς, μελάνωμα και καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (National Cancer Institute, 2023).

Στην Ευρώπη, τα στατιστικά επιβεβαιώνουν εν πολλοίς την ίδια εικόνα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη σε 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 5 πρώτοι σε εμφάνιση τύποι καρκίνου σε ΑΥΑ ασθενείς είναι ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος των όρχεων, ο καρκίνος της μήτρας, ο καρκίνος του θυροειδούς και τέλος το μελάνωμα (με φθίνουσα σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα ποσοστά εμφάνισής τους).

Αυτό που διαφέρει, όμως, στα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι ότι υπάρχει μια διακύμανση μέσα σε αυτά που βασίζεται στο δίπτυχο Ανατολής-Δύσης μέσα στην Ευρώπη. Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι ανατολικότερες χώρες της Ευρώπης έχουν μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας για πολλούς τύπους καρκίνου, σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Το δεδομένο αυτό δεν είναι απροσδόκητο, καθώς οι χώρες αυτές έχουν και μικρότερο ποσοστό επιβίωσης από τον καρκίνο, τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι πιο θανάσιμες μορφές καρκίνου στους ΑΥΑ ασθενείς στην Ευρώπη είναι ο γυναικείος καρκίνος του μαστού, οι όγκοι του ΚΝΣ και οι όγκοι του ουροποιητικού και τραχήλου της μήτρας (Trama *et al.*, 2023).

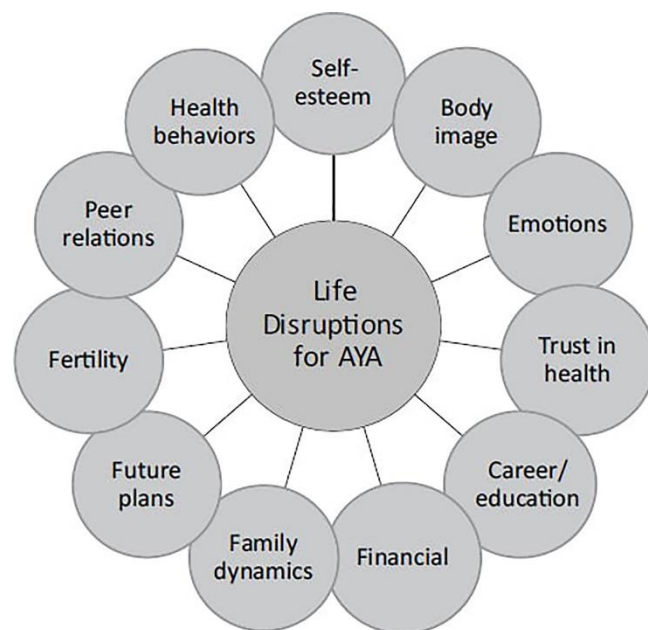


Εικόνα 1. Συχνότητα εμφάνισης καρκίνου (αριστερά) και θνησιμότητα (δεξιά), ανά την Ευρώπη, για το 2020 (Trama *et al.*, 2023)

2.2 Ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής στον καρκίνο

2.2.1 ΑYA ασθενείς

Οι ΑYAs επιζώντες από καρκίνο βιώνουν μακροπρόθεσμα τις δευτερογενείς συνέπειες της ασθένειας σε διάφορους τομείς της ζωής τους (Fisher *et al.*, 2018). Δηλαδή, η ευαλωτότητα και μεταβλητότητα της εφηβείας, σε συνδυασμό με τη διάγνωση ενός καρκίνου, δημιουργούν μία ιδιαίτερη συνθήκη, με ξεχωριστές, αναπτυξιακές ανάγκες για τους εφήβους στην αναδυόμενη ενηλικίωση (Kazak *et al.*, 2010). Οι προσπάθειες για τη κάλυψη των αναγκών αυτών αφορά την επίτευξη αυτονομίας από τους γονείς, η ολοκλήρωση του σχολείου, η είσοδος στην αγορά εργασίας με μια επιθυμητή γι' αυτούς εργασία, η εύρεση ερωτικού συντρόφου και η δημιουργία οικογένειας. Πολλές από αυτές, όμως, εκτροχιάζονται με τον ερχομό της διάγνωσης. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται κάποιες από αυτές (Nass and Patlak, 2014).



Εικόνα 2. Απεικόνιση των ιδιαίτερων αναγκών που διαταράσσονται σε έφηβους και νέους ενήλικες με καρκίνο (Nass and Patlak, 2014)

Όπως υπογραμμίζει και η Karen Fasciano, κλινική ψυχολόγος στην ιατρική σχολή του Harvard, πολλά από τα παραπάνω ορόσημα στη για τους εφήβους και νέους ενήλικες, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ασθένειά τους. Όταν, δηλαδή, το αναπτυξιακό τους στάδιο προτάσσει ανάγκη για ανεξαρτησία και έλεγχο στα πράγματα της ζωής τους, οι απαιτήσεις της ασθένειας τους καθηλώνουν σε μία φάση μοναξιάς, εξάρτησης από τους άλλους (γονείς, προσωπικό υγείας), ευαλωτότητας. Όταν περισσότερο από ποτέ –στην εφηβεία- χρειάζεται να νιώθουν το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια ομάδα συνομηλίκων, τότε η ασθένεια μπαίνει εμπόδιο σε αυτό. Στο πιο καίριο σημείο για την ανάπτυξη της σεξουαλικής τους ταυτότητας, η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να έχει επιπτώσεις στη σεξουαλική τους υγεία και στην αίσθηση ελκυστικότητας που έχουν για τον εαυτό τους. Παράλληλα, στη περίοδο που αναπτύσσονται ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (όπως η οργάνωση, η αυτό-παρατήρηση, η ευελιξία, η αφηρημένη σκέψη), η θεραπεία του καρκίνου συνήθως τους απομακρύνει από τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές διαδικασίες. Ενώ έχουν τόσο ανάγκη να ονειρευτούν και να προγραμματίσουν το μέλλον τους, το μέλλον τους μοιάζει αβέβαιο (Nass and Patlak, 2014).

Φαίνεται ότι όλες οι παραπάνω προκλήσεις καθιστούν τους εφήβους και νέους ενήλικες με καρκίνο ευάλωτους για προβλήματα ψυχικής υγείας. Στη πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση που βρέθηκε, αυτή των Osmani και συνεργατών (2023), οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι οι ΑYA επιζώντες από καρκίνο εμφανίζουν κατάθλιψη και άγχος με ποσοστά επιπολασμού 24%-32%. Ενώ, προηγούμενες μελέτες αναφέρουν ένα εύρος επιπολασμού για τις ίδιες διαταραχές, 8%-42%. Τα ποσοστά αυτά είναι σίγουρα μεγαλύτερα από αυτά που ισχύουν για το γενικό πληθυσμό νέων ενηλίκων (15-39 ετών): περίπου 4% στη κατάθλιψη και 5% στις αγχώδεις διαταραχές (Osmani *et al.*, 2023). Παράλληλα, σε μια συστηματική ανασκόπηση της ίδιας χρονιάς, αυτή των Tanner και συνεργατών (2023), προτείνεται ότι υπάρχει μία σημαντική περίοδος ευαλωτότητας για τη ψυχική υγεία των ΑYA ασθενών με καρκίνο, η οποία όμως δεν είναι απαραίτητα παρούσα με τη πάροδο των χρόνων. Με λίγα λόγια υποστηρίζουν ότι μάλλον υπάρχουν σημάδια του καρκίνου στη ψυχική υγεία των ΑYA ασθενών, αλλά αυτά ενδεχομένως δε μένουν ανεξίτηλα στο χρόνο, αλλά ξεπερνιούνται από τα υποκείμενα (Tanner *et al.*, 2023).

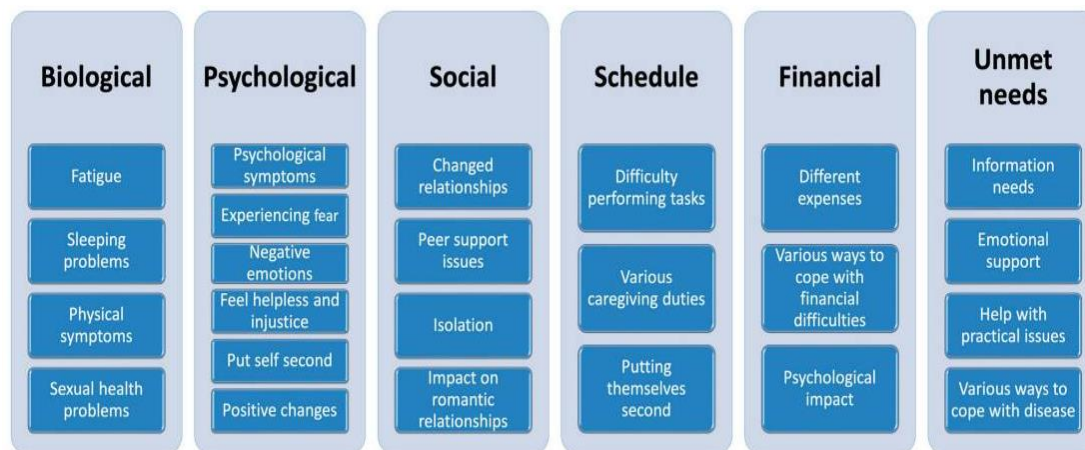
Εξετάζοντας την υγεία των εφήβων και νέων ενηλίκων υπό το πρίσμα της ποιότητας ζωής τους, φαίνεται ότι οι ΑYA ασθενείς με χρόνιες ασθένειες

παρουσιάζουν και εκεί ορισμένες εκπώσεις. Η ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία (HRQOL) αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη συνολικής υγείας, καθώς καταγράφει την κατάσταση της φυσικής και ψυχικής υγείας των ατόμων, καθώς και την επίδραση της υγείας στην ποιότητα ζωής τους. Συνήθως, η HRQOL αξιολογείται μέσω πολλών δεικτών που αφορούν την αυτοεκτίμηση της υγειονομικής κατάστασης, καθώς και τη φυσική και συναισθηματική λειτουργικότητα. Αυτοί οι δείκτες παρέχουν μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της επιβάρυνσης που προκαλούν οι χρόνιες ασθένειες, τραυματισμοί και αναπηρίες (Yin *et al.*, 2016). Όπως αναφέρεται και σε πρόσφατη μελέτη των Wang και συνεργατών (2023), οι χρόνιες ασθένειες μπορεί να επηρεάσουν τη ποιότητα ζωής των ΑYA ασθενών αγγίζοντας διάφορους τομείς της ζωής τους, όπως ο σωματικός, ο ψυχικός, καθώς και ο κοινωνικός. Πιο συγκεκριμένα οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι έφηβοι και νέοι ενήλικες που ήταν γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας, με κάποια χρόνια ασθένεια και ήταν σε φαρμακευτική αγωγή είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταταγούν σε κάποιο προφίλ με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Ενώ, οι ΑYA ασθενείς που βίωναν χρόνιο πόνο ανέφεραν επίσης σημαντικές επιπτώσεις στη φυσική, ψυχική και κοινωνική τους ευημερία (Wang *et al.*, 2023).

2.2.2 Οικείοι των ΑYA ασθενών

Το βίωμα του καρκίνου είναι προφανές ότι επηρεάζει, εκτός από τους ίδιους του ασθενείς, και τους οικείους τους. Ήδη από τη δεκαετία του 90', η Kazak και συνεργάτες (1997) ερευνούν τη ψυχική υγεία των γονέων παιδιών με λευχαιμία και βρίσκουν αυξημένα συμπτώματα μετατραυματικού στρες, τόσο για τις μητέρες, όσο και για τους πατέρες παιδιών-ασθενών, συγκριτικά με γονείς υγιών παιδιών (Kazak *et al.*, 1997). Πιο πρόσφατα, η μετα-ανάλυση των Pai και συνεργατών (2007) καταλήγει, επίσης, στο ότι οι γονείς παιδιών με καρκίνο αναφέρουν εντονότερη ψυχική δυσφορία, έναντι των γονέων με παιδιά χωρίς ιστορικό καρκίνου (Pai *et al.*, 2007). Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα αποτελέσματα πολύ πρόσφατης μετα-ανάλυσης που εξετάζει τα επίπεδα μετατραυματικού στρες και την ύπαρξη μετατραυματικών διαταραχών, σε γονείς εφήβων με κάποια χρόνια ασθένεια. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα ποσοστά διάγνωσης Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) σε γονείς εφήβων με χρόνιες ασθένειες ήταν πολλαπλάσια εκείνων του γενικού πληθυσμού. Τα σημαντικότερα ποσοστά βρέθηκαν σε γονείς ασθενών που έπασχαν από επιληψία, διαβήτη, αναιμία,

καρδιαγγειακές νόσους, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών βρέθηκε στους γονείς με έφηβο καρκινοπαθή (Pinquart, 2019).



Εικόνα 3. Οι τομείς επιβάρυνσης των φροντιστών ΑYA ασθενών με καρκίνο (Reuvers et al., 2023)

Η χρόνια ασθένεια ενός παιδιού ή εφήβου είναι μία πρόκληση που εγκυμονεί κινδύνους και άγχος, απαιτεί προσαρμογές και αλλαγές, όχι μόνο για το ίδιο το άτομο-ασθενή, αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά του (Knecht, Hellmers and Metzing, 2015). Έτσι, πλήττονται από αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη και τα αδέρφια των εφηβων ασθενών.

Όσον αφορά τον καρκίνο συγκεκριμένα, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν την επιβαρυσμένη ψυχική υγεία των αδερφών, εφηβων ασθενών με καρκίνο. Κάποιες από αυτές, εντοπίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και ψυχικής δυσφορίας σε αδέρφια ασθενών με καρκίνο (Silver and Frohlinger-Graham, 2000; Patterson, Medlow and McDonald, 2015). Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι έφηβα αδέρφια ασθενών με καρκίνο παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα μετατραυματικού στρες σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που αποτελούνταν από έφηβους χωρίς αδέρφια με καρκίνο (Barakat, Alderfer and Kazak, 2006). Επίσης, σε νεότερη μελέτη των McDonald και συνεργατών (2015) φαίνεται ότι τα αδέρφια ΑYA ασθενών με καρκίνο, που βρίσκονται σε θεραπεία ή υποτροπή, δηλώνουν περισσότερες ανεκπλήρωτες ανάγκες από την οικογένεια και τους γύρω τους. Αυτό συχνά συμβαίνει, επειδή οι γονείς περνούν τις περισσότερες ώρες εκτός σπιτιού (στο νοσοκομείο) και

αυτό δημιουργεί στα αδέρφια την αίσθηση μιας ψυχικής δυσφορίας που προκύπτει από τη μη εκπλήρωση των αναγκών τους (McDonald *et al.*, 2015; Patterson, Medlow and McDonald, 2015).

2.3 Κοινωνική υποστήριξη

2.3.1 Ορισμός και βασικά στοιχεία

Η κοινωνική υποστήριξη από το κοινωνικό μας δίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Το αντίθετο της καλής κοινωνικής υποστήριξης είναι η μοναξιά. Φαίνεται ότι η κοινωνική υποστήριξη περιλαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινωνική κοινότητα, την εκτίμηση, πρακτική βοήθεια, καθώς και πληροφόρηση και καθοδήγηση. Η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί έναν ζωτικό, ευεργετικό πόρο για την ψυχική υγεία των ατόμων.

Όπως ορίζουν οι Lakey και Cohen (2000), η κοινωνική υποστήριξη αφορά την αίσθηση που έχει κανείς για την ύπαρξη βοήθειας από τους «σημαντικούς άλλους», όταν αυτή χρειάζεται, καθώς και το κατά πόσο είναι ευχαριστημένος από την βοήθεια που του έχει ήδη δοθεί στο παρελθόν (Lakey, Brian; Cohen, 2000). Στη μελέτη γύρω από τη κοινωνική υποστήριξη υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά τη ποσοτική της μέτρηση και ένα άλλο που σχετίζεται με τη ποιοτική της έκφραση. Το πρώτο αποτυπώνεται εν πολλοίς στη μέτρηση του κοινωνικού δικτύου που διαθέτει ένας άνθρωπος, ενώ το δεύτερο συχνά αφορά τη διάκριση της κοινωνικής υποστήριξης στις εξής πτυχές: συναισθηματική, πληροφοριακή, πρακτική. Φαίνεται ότι και τα δύο κομμάτια της κοινωνικής υποστήριξης παίζουν το ρόλο τους στη ψυχική υγεία των υποκειμένων. Αυτό που ίσως αλλάζει τα πράγματα είναι το ποιος τύπος κοινωνικής υποστήριξης παρέχεται από κάθε διαφορετική υπό-ομάδα του κοινωνικού δικτύου (δηλ. οικογένεια, φίλοι, συγγενείς, ιατρικό προσωπικό).

Μία άλλη βασική διάκριση που γίνεται στην επιστημονική κοινότητα είναι αυτή μεταξύ «αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης» (perceived social support) και της «λαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης» (received social support). Η πρώτη αναφέρεται στην υποκειμενική αίσθηση που έχει το άτομο ότι η υποστήριξη έχει

προσφερθεί ή πρόκειται να προσφερθεί από τον κοινωνικό του περίγυρο, ενώ η δεύτερη αφορά την πραγματικά ληφθείσα κοινωνική υποστήριξη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μόνο η αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη έχει συνδεθεί άμεσα με καλύτερη ψυχική υγεία, ενώ η ληφθείσα κοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη δε φαίνεται να σχετίζονται άμεσα. Με λίγα λόγια, φαίνεται ότι η πεποίθηση ότι η βοήθεια είναι διαθέσιμη όταν χρειαστεί είναι αυτή που έχει αληθινά ευεργετικό ρόλο στην υγεία των ανθρώπων και όχι απαραίτητα η βοήθεια που παρέχεται στη πραγματικότητα (Haugan and Eriksson, 2021).

2.3.2. Κοινωνική υποστήριξη σε ΑYA ασθενείς με καρκίνο

Συγκεκριμενοποιώντας τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας στους εφήβους με κάποια χρόνια ασθένεια, φαίνεται ότι ακολουθούν την ίδια πορεία. Σε πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση, προτείνεται η κοινωνική υποστήριξη ως ένας προστατευτικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής των χρονίως ασθενών εφήβων (Santos *et al.*, 2019). Παράλληλα, υπάρχει μία πληθώρα ερευνών που υποστηρίζουν τη συσχέτιση της κοινωνικής υποστήριξης με καλύτερη ψυχική υγεία ΑYA ασθενών με καρκίνο. Κάποιες από αυτές είναι ποσοτικές μελέτες που υπογραμμίζουν, εν πολλοίς, τη συσχέτιση κοινωνικής υποστήριξης με διάφορους παράγοντες ψυχικής υγείας, όπως μικρότερο ψυχολογικό βάρος και στρες (Tillery *et al.*, 2017; Liu *et al.*, 2021), αλλά και περισσότερο θετικό συναίσθημα (Wesley, Zelikovsky and Schwartz, 2013). Ενώ, άλλη μελέτη αναφέρεται στην κοινωνική υποστήριξη ως έναν προγνωστικό παράγοντα καλής ψυχικής υγείας για τους εφήβους και νέους ενήλικες ασθενείς με καρκίνο (Corey *et al.*, 2008).

Υποστηρικτικά, επίσης, είναι και τα δεδομένα από τις ποιοτικές μελέτες για τη σημασία της κοινωνικής υποστήριξης σε τέτοιες καταστάσεις. Στις ποιοτικές αυτές μελέτες, χρησιμοποιούνται συχνά ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς ή διενεργούνται ημιδομημένες συνεντεύξεις. Οι ΑYA ασθενείς περιγράφουν οι ίδιοι το βίωμά τους, δίνοντας μια ποιοτική, ρεαλιστική, ολιστική εικόνα για το τί πραγματικά θεωρούν βοηθητικό και τί όχι στη μάχη τους με τον καρκίνο. Εκεί, λοιπόν, συχνά αναφέρεται από τους ίδιους η σημασία της υποστήριξης από το ιατρικό προσωπικό (Zebrack, Chesler and Kaplan, 2010; Steinberg *et al.*, 2020), από την οικογένεια (Ritchie, 2001) και από τους συνομηλίκους (D'Agostino, Penney and Zebrack, 2011).

Ιδιαίτερης σημασίας φαίνεται να είναι η κοινωνική υποστήριξη που προέρχεται από τους συνομηλίκους. Πολλές έρευνες δίνουν βάση στο ρόλο της υποστήριξης των συνομηλίκων, είτε προέρχεται από υγιείς, είτε προέρχεται από άλλους ΑYA ασθενείς με καρκίνο. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, συσχετίζουν τη προερχόμενη από υγιείς συνομηλίκους υποστήριξη, με χαμηλότερο ψυχολογικό βάρος (Tillery *et al.*, 2017) και περισσότερο θετικό συναίσθημα για τους ασθενείς (Wesley, Zelikovsky and Schwartz, 2013). Ενώ, η ύπαρξη συνομηλίκων ΑYA ασθενών με καρκίνο φαίνεται να παίζει, επίσης σημαντικό ρόλο, προσφέροντας στους ασθενείς μια οικειότητα στο μοίρασμα των κοινών εμπειριών τους και έτσι μεγαλύτερη σύνδεση (Zebrack, Chesler and Kaplan, 2010).

Η ιδιαιτερότητα της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης έγκειται στο ότι συμπεριλαμβάνει την κοινωνική υποστήριξη ως βασική συνισταμένη στη ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής όχι μόνο των ίδιων των ασθενών, αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος αυτών. Ειδικότερα, τα αδέρφια ΑYA ασθενών με καρκίνο είναι ένας πληθυσμός που, όπως φαίνεται, δεν έχει μελετηθεί ενδελεχώς.

2.3.3 Κοινωνική υποστήριξη στους οικείους ΑYA ασθενών με καρκίνο

Μία διάγνωση καρκίνου σε έναν έφηβο ή νέο ενήλικα δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο, αλλά διαταράσσει και την ισορροπία όλης της οικογένειας. Οι γονείς συχνά βιώνουν έντονο συναισθηματικό φορτίο, ενώ τα αδέρφια των ασθενών συχνά αισθάνονται παραμέληση των αναγκών τους, λόγω της ασθένειας των έφηβων αδερφών τους. Η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται εδώ να παίζει σημαντικό ρόλο στη καλύτερη προσαρμογή της οικογένειας στην ασθένεια ΑYA ασθενούς με καρκίνο. Ήδη από το 1988, οι Magnil και συνεργάτες επιβεβαιώνουν την θετική συσχέτιση της κοινωνικής υποστήριξης με την καλύτερη προσαρμογή της οικογένειας στην ασθένεια του παιδιού με λευχαιμία. Ενώ από την ίδια έρευνα φαίνεται, ότι ένα επαρκές δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης παίζει επίσης βοηθητικό ρόλο στη καλύτερη προσαρμογή, τόσο των μητέρων, όσο και των πατέρων, στην ασθένεια του παιδιού τους (Magni *et al.*, 1988).

Από τότε και μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετές έρευνες που επιβεβαιώνουν τον ευεργετικό χαρακτήρα της κοινωνικής υποστήριξης στους γονείς με έφηβο

καρκινοπαθή (Speechley and Noh, 1992; Kazak *et al.*, 1997; Choi *et al.*, 2016; Melguizo-Garín *et al.*, 2022). Σε βιβλιογραφική ανασκόπηση της περασμένης χρονιάς, οι Reuvers και συνεργάτες (2023) αναφέρουν αντίστοιχα αποτελέσματα. Δηλαδή, οι ίδιοι οι γονείς έφηβων ασθενών με καρκίνο αναφέρουν ότι η υποστήριξη από τρίτους, όπως το υγειονομικό προσωπικό, άλλοι γονείς με έφηβους καρκινοπαθείς και οικογενειακοί φίλοι, ήταν μια βοηθητική συνθήκη γι' αυτούς στη μάχη με τον καρκίνο. Εν προκειμένω, το μοίρασμα της δυσκολίας της κατάστασης και των προσπαθειών που καταβάλουν οι γονείς ήταν αυτό που δρούσε ευεργετικά για τους τελευταίους (Reuvers *et al.*, 2023).

Ειδικό μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κύριος ερευνητικός στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής των έφηβων και νέων ενηλίκων με καρκίνο, σε σχέση με το ίδιο το βίωμα του καρκίνου. Εξετάζονται, δηλαδή, οι συνέπειες που ενδέχεται να έχει μια διάγνωση καρκίνου σε ΑΥΑ ασθενείς, όσον αφορά τη ψυχοκοινωνική τους ευημερία. Παράλληλα, διερευνάται η ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής των γονέων και αδερφών των ασθενών, ως έμμεσα επηρεαζόμενων από τη συνθήκη. Τέλος, σημαντική μεταβλητή στη παρούσα διατριβή καθίσταται η κοινωνική υποστήριξη, τόσο στους ίδιους τους ασθενείς, όσο και στους οικείους τους. Μελετάται, δηλαδή, και η επίδραση που μπορεί να έχει η αντιλαμβανόμενη ή και λαμβάνουσα κοινωνική υποστήριξη, στη ψυχική υγεία των ασθενών και των οικείων τους. Από τα παραπάνω προκύπτουν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις:

1. Η ψυχική υγεία και η ποιότητα ζωής των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με καρκίνο είναι επιβαρυνμένη σε σχέση με τους υγιείς συνομηλίκους τους.
2. Οι οικείοι (γονείς, αδέρφια)/φροντιστές των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με καρκίνο αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικής υγείας και εκπτώσεις στη ποιότητα ζωής τους.
3. Η ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής τόσο των ίδιων των εφήβων ασθενών με καρκίνο, όσο και των οικείων τους, σχετίζεται με τη κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνουν.

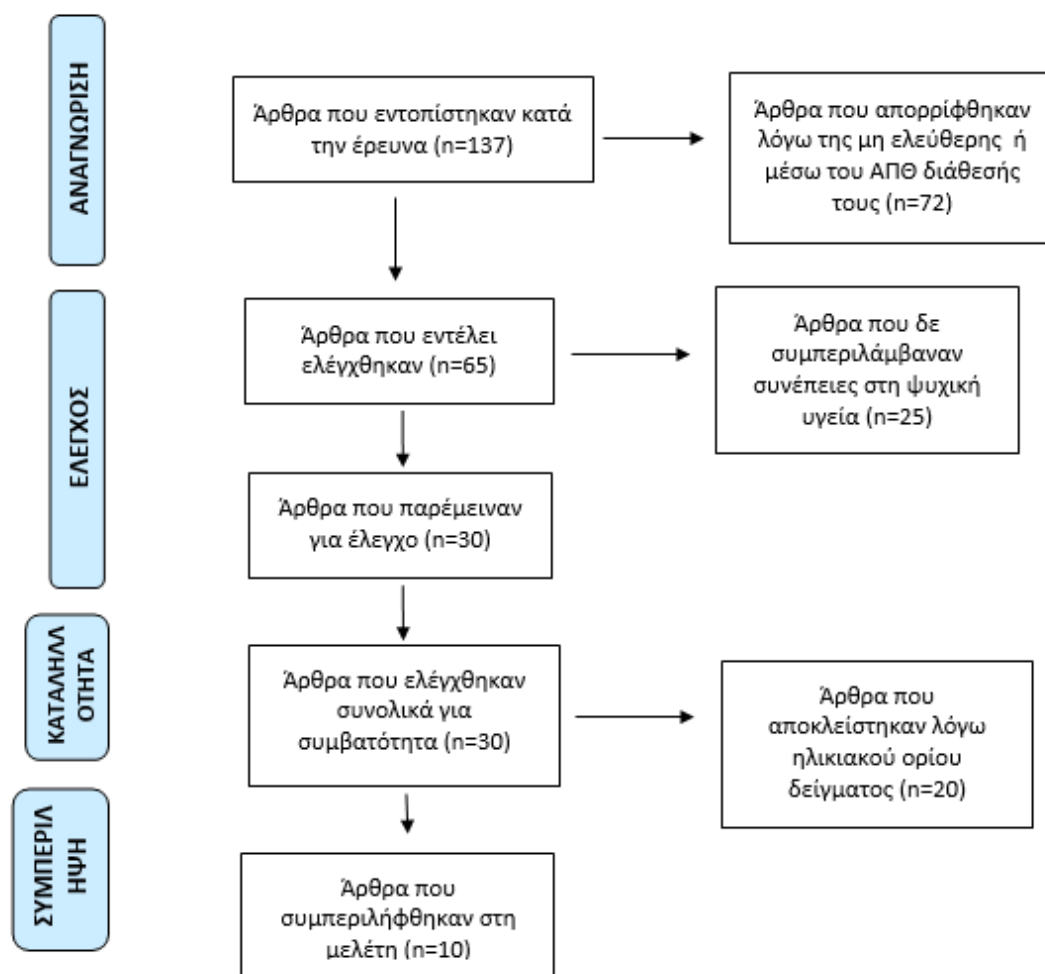
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για τη παρούσα περιγραφική ανασκόπηση έγινε μια εκτενής βιβλιογραφική έρευνα στις παρακάτω βάσεις δεδομένων: PubMed, PsychInfo, ScienceDirect, Scopus. Οι εκδοτικοί οίκοι Wiley και Taylor & Francis ήταν ακόμη μία πηγή άντλησης μελετών, ενώ χρησιμοποιήθηκε και το ακαδημαϊκό μέσο κοινωνική δικτύωσης: ResearchGate. Οι κυριότερες λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στις βάσεις δεδομένων ήταν: καρκίνος, έφηβοι, νέοι ενήλικες, χρόνια ασθένεια, ασθενείς με καρκίνο, επιζώντες από καρκίνο, γονείς, αδέρφια, ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής, κοινωνική υποστήριξη, άγχος, κατάθλιψη, ψυχολογικό βάρος, ψυχική δυσφορία, προσαρμογή. Ελέγχθηκαν, επίσης, όλες οι λίστες παραπομπών των επιλεγμένων άρθρων, διαδικασία η οποία ανέδειξε περαιτέρω χρήσιμο και σχετικό υλικό. Τέλος, για την αρχειοθέτηση και επεξεργασία των επιλεχθέντων ερευνών χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή βιβλιοθήκη Mendeley Desktop. Συνοπτικά τα κριτήρια επιλογής στη παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν:

- Η ελεύθερη διάθεσή τους στο διαδίκτυο ή δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω των υπηρεσιών του ΑΠΘ (HEAL-Link)
- Να μελετούν κάποια συνέπεια στη ψυχική υγεία (π.χ. άγχος, κατάθλιψη) ή ποιότητα ζωής
- Να εμπίπτουν στο ηλικιακό όριο δείγματος (≤ 11 έτη)

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψαν αρχικά 137 έρευνες σχετικές με το υπό διερεύνηση θέμα. Από αυτές οι 65 ήταν αυτές που έμειναν, εφαρμόζοντας τα κριτήρια επιλογής για την ελεύθερη διάθεσή τους στο διαδίκτυο ή τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του ΑΠΘ. Στη συνέχεια αποκλείστηκαν 25 μελέτες, λόγω του ότι δεν συμπεριλάμβαναν κάποια συνέπεια στη ψυχική υγεία (π.χ. κατάθλιψη/άγχος/ψυχολογική επιβάρυνση) ή στην ποιότητα ζωής των ασθενών ή φροντιστών. Προέκυψαν 30 μελέτες που ήταν προσβάσιμη η ελεύθερη μορφή τους στο διαδίκτυο (ή μέσω του ΑΠΘ) και μετρούσαν τις μεταβλητές που σχετίζονται με τη παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από αυτές, αποκλείστηκαν 20, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την ηλικία του δείγματος. Το κριτήριο αυτό ήταν οι

συμμετέχοντες στις έρευνες να έχουν μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 11 χρόνια, το ορόσημο δηλαδή για την είσοδο στην εφηβική ηλικία. Έτσι προκύπτουν 10 έρευνες της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίες και θα μελετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος παρακάτω. Παρακάτω, διαγραμματικά η επιλογή και ανασκόπηση των άρθρων.



Διάγραμμα 2. Διαδικασία επιλογής και ανασκόπησης άρθρων για τη διεξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

5.1.1 ΑYA ασθενείς

Στη παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουν συμπεριληφθεί 10 μελέτες, εκ των οποίων 1 συστηματική ανασκόπηση, 2 μετα-αναλύσεις, 2 συσχετιστικές μελέτες, 1 μελέτη αιτιακών σχέσεων, 1 βιβλιογραφική ανασκόπηση, 2 διαχρονικές μελέτες και 1 δευτερογενή μελέτη σε δεδομένα βασισμένα σε προγενέστερη μελέτη. Ως μια γενική εικόνα, φαίνεται ότι οι μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία που αφορούν τη ψυχική υγεία ΑYA ασθενών με καρκίνο, αλλά και των φροντιστών τους είναι περιορισμένες. Ενώ υπάρχουν μελέτες που αναλύουν τη ψυχική υγεία παιδιών με καρκίνο, οι μελέτες που προσανατολίζονται στην εφηβική ηλικία και την πρώτη ενήλικη ζωή είναι πολύ λιγότερες. Παρ' όλα αυτά βρίσκονται ορισμένες μελέτες που μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλή αποτελέσματα.

Στην πολύ πρόσφατη μετα-ανάλυση των Osmani και συνεργατών (2023), φαίνεται ότι η ψυχική υγεία των ΑYA επιζώντων από καρκίνο είναι επιβαρυνμένη, σε σύγκριση με υγιή άτομα της ίδιας ηλικίας. Δηλαδή, ο επιπολασμός άγχους, κατάθλιψης και ψυχολογικού βάρους σε έφηβους και νέους ενήλικες ασθενείς με καρκίνο είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού (Osmani *et al.*, 2023).

Σε αντίστοιχη τροχιά βρίσκονται και τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης των Tanner και συνεργατών (2023), στην οποία συγκεντρώνονται αποτελέσματα άλλων ερευνών. Οι συγγραφείς ερευνούν τη ψυχική υγεία έφηβων και νέων ενηλίκων με καρκίνο, συμπεριλαμβάνοντας την αυτό-αναφορική άποψη των ίδιων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν πως οι ΑYA επιζώντες από καρκίνο έχουν χειρότερη ψυχική υγεία, σε σχέση με υγιείς συνομηλίκους, καθώς και υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης (Tanner *et al.*, 2023).

Τα παραπάνω στοιχεία πλαισιώνει και η δευτερογενής μελέτη των Wang και συνεργατών (2023). Οι ερευνητές διακρίνουν διάφορα προφίλ με κριτήριο την ποιότητα ζωής των ΑYA ασθενών με διάφορες σωματικές (συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου) ή και ψυχικές ασθένειες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι έφηβοι και νέοι ενήλικες που ήταν γυναίκες, μεγαλύτερες σε ηλικία, είχαν χρόνιες σωματικές ασθένειες και ήταν σε φαρμακευτική αγωγή, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανήκουν στο προφίλ των ανθρώπων που επηρεάζεται σοβαρότερα η ποιότητα ζωής τους. Συγκεκριμένα το προφίλ αυτό συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα θυμού, κατάθλιψης, άγχους, κόπωσης και επίδρασης του πόνου στη κοινωνικότητα και συμμετοχή. Αναφορικά με τον πόνο, οι έφηβοι και νέοι ενήλικες που βιώνουν πόνο αναφέρουν συχνά ότι αυτό σχετίζεται με τη φυσική, σωματική και κοινωνική ποιότητα ζωής τους (Wang *et al.*, 2023).

Στην επίσης πρόσφατη, μόλις του περασμένου χρόνου και μοναδική διαχρονική μελέτη της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης βρίσκονται αντίστοιχα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα ο Harper και συνεργάτες (2023) διενεργούν μια διαχρονική μελέτη στον Καναδά, με δείγμα έφηβους και νέους ενήλικες με καρκίνο, παρέχοντας αυτό-αναφορικά ερωτηματολόγια σε αυτούς, σε δύο φάσεις: κατά τη διάγνωση (0-60 μέρες από τη διάγνωση) και 1 χρόνο μετά (301-360 μέρες μετά). Οι συγγραφείς βρίσκουν ότι η κόπωση, το άγχος και η κακή ευημερία ήταν οι μεγαλύτερες ανησυχίες των έφηβων και νέων ενήλικων ασθενών με καρκίνο, τόσο κατά τη διάγνωση, όσο και ένα χρόνο μετά από αυτή. Μάλιστα, βρίσκουν ότι παρ' όλο που όλα τα συμπτώματα φαίνεται να βελτιώνονται ένα χρόνο μετά τη διάγνωση, αυτό δε συμβαίνει στη περίπτωση της κατάθλιψης και του πόνου. Εκεί, εμφανίζονται ελάχιστες αλλαγές, γεγονός που ίσως καταδεικνύει, κατά τους συγγραφείς, ότι οι έφηβοι και νέοι ενήλικες ασθενείς αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένοι κατά τη διαδικασία των ογκολογικών θεραπειών τους, λόγω του ότι είναι αναγκασμένοι να συνυπάρχουν με σημαντικά μεγαλύτερους ηλικιακά ενήλικες. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της μελέτης των Harper και συνεργατών (2023) υπογραμμίζουν ότι οι νεότεροι ενήλικες και έφηβοι διατρέχουν σημαντικά σοβαρότερο κίνδυνο για εμφάνιση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, κατά τη διάγνωση, από τους μεγαλύτερους ενήλικες, ενώ επίσης σοβαρότερα συμπτώματα παρουσιάζουν και στο follow-up. Πιο συγκεκριμένα, 1 χρόνο μετά οι πιθανότητες να εμφανίσουν μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα πόνου και κόπωσης ήταν 1,4 φορές μεγαλύτερες για τους ΑYA ασθενείς, συγκριτικά με τους

γηραιότερους ενήλικες, ενώ 2,4 φορές μεγαλύτερες για την εμφάνιση άγχους (Harper *et al.*, 2023).

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ	ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Baezinger et al., 2024	• 24 χρόνια μετά τη διάγνωση, ίδια ή και λιγότερα επίπεδα μετατραυματικών συμπτωμάτων για γονείς ΑYA επιζώντων από καρκίνο, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.
Choi et al., 2016	• 51% φροντιστών παιδιών με όγκο στον εγκέφαλο πληρούσαν τα κριτήρια για κατάθλιψη. • Οι φροντιστές με υψηλά αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη ανέφεραν λιγότερη ψυχολογική επιβάρυνση.
Harper et al., 2023	• 1 χρόνο μετά τη διάγνωση, οι έφηβοι και νέοι ενήλικες με καρκίνο είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες για κατάθλιψη και άγχος, συγκριτικά με τους γηραιότερους ενήλικες. • Οι ΑYA ασθενείς αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένοι κατά τις θεραπείες, λόγω του ότι παλαισιώνονται από σημαντικά γηραιότερους ενήλικες.
Liu et al., 2021	• Η κοινωνική υποστήριξη ως άμεσος προβλεπτικός παράγοντας του ψυχολογικού στρες σε παιδιά με κακοήθεις όγκους. • Έμμεση επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης, μέσω των στρατηγικών διαχείρισης της ασθένειας και των πεποιθήσεων αυτό-αποτελεσματικότητας, σε παιδιά με κακοήθεις όγκους.
McDonald et al., 2015	• Υψηλότερος κίνδυνος για ψυχολογική επιβάρυνση και ανεκπλήρωτες ανάγκες σε αδέρφια ΑYA ασθενών με καρκίνο, κατά τη θεραπεία και υποτροπή.

Osmani et al., 2023	• Οι ΑYA επιζώντες από καρκίνο, χωρίς σύντροφο είχαν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικού βάρους, σε σύγκριση με αυτούς που είχαν συντροφική σχέση. • Η απουσία από το σχολείο ή τη δουλειά συνδέθηκε με περισσότερο ψυχ. βάρος, πιθανόν λόγω έλλειψης υποστήριξης από συνομηλίκους.
Pinquart, 2019	• Αρνητική συσχέτιση μεταξύ πηγών κοινωνικής υποστήριξης και συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες. Η ύπαρξη συντρόφου και κοινωνικής υποστήριξης ως προστατευτικός παράγοντας για την ανάπτυξη συμπτωμάτων PTSD, σε γονείς παιδιών και εφήβων με χρόνιες σωματικές ασθένειες.
Reuvers et al., 2023	• Αδέρφια ΑYA ασθενών με καρκίνο αναφέρουν αισθήματα μοναξιάς και ανεκπλήρωτες ανάγκες κατά τη διάρκεια των θεραπειών των αδερφών τους. • Γονείς ΑYA ασθενών με καρκίνο αναφέρουν τη κοινωνική υποστήριξη από ιατρικό προσωπικό και άλλους γονείς με αντίστοιχες δυσκολίες, ως βοηθητική συνθήκη γι' αυτούς.
Tanner et al., 2023	• Χειρότερη ψυχική υγεία για ΑYA επιζώντες από καρκίνο, συγκριτικά με υγιείς συνομηλίκους. • Ψυχική ευαλωτότητα κατά την πρώτη περίοδο μετά την ασθένεια για ΑYA επιζώντες από καρκίνο, η οποία δε διαρκεί μακροπρόθεσμα.
Wang et al., 2023	• Η διάγνωση καρκίνου, ο πόνος και η φαρμακευτική αγωγή κατατάσσουν τους εφήβους με χρόνια ασθένεια, στο προφίλ με χειρότερη ποιότητα ζωής που συνδέεται με περισσότερο θυμό, άγχος, κατάθλιψη και κόπωση.

5.1.2 Γονείς/φροντιστές ΑYA ασθενών

Αναφορικά με τους γονείς/φροντιστές ΑYA ασθενών με καρκίνο η εικόνα φαίνεται να είναι πιο σύνθετη. Ο Pinguart (2019) στη μετα-ανάλυσή του, μελετάει την ανάπτυξη μετατραυματικών συμπτωμάτων και διαταραχών σε γονείς παιδιών και εφήβων με χρόνιες, σωματικές ασθένειες. Οι έφηβοι με καρκίνο αποτελούν τη πιο αντιπροσωπευτική υπο-ομάδα με αντιπροσώπευση πάνω από 50% επί του δείγματος της μελέτης. Ο συγγραφέας καταλήγει στο ότι οι γονείς εφήβων ασθενών με κάποια σωματική ασθένεια –συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου- έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν μετατραυματικό στρες, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Σημειώνεται επίσης, ότι τα επίπεδα εμφάνισης συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες ήταν υψηλότερα για τις μητέρες, παρά για τους πατέρες των εφήβων με καρκίνο (Pinguart, 2019).

Στην ίδια τροχιά κυμαίνονται και τα αποτελέσματα της συσχετιστικής μελέτης των Choi και συνεργατών (2016) με δείγμα παιδιών με καρκίνο του εγκεφάλου που είναι σε θεραπεία. Η εν λόγω μελέτη συμπεριλαμβάνεται στη παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών είναι σχεδόν τα 11 έτη, ηλικία που συμπίπτει εν πολλοίς με την έναρξη της εφηβικής ηλικίας. Τα ποσοστά κατάθλιψης που διαπιστώνονται για τους γονείς ΑYA ασθενών με καρκίνο είναι υψηλά και υπογραμμίζουν την ευαλωτότητά τους (Choi *et al.*, 2016)

Στον αντίποδα των παραπάνω αποτελεσμάτων έρχεται η πρόσφατη, διαχρονική μελέτη των Baenziger και συνεργατών (2024). Πρόκειται για μία ελβετική, συγχρονική μελέτη που γίνεται σε εθνικό επίπεδο και μελετάει την ανάπτυξη συμπτωμάτων και διαταραχών μετατραυματικού στρες σε γονείς παιδιών επιζώντων από καρκίνο, σε σύγκριση με γονείς παιδιών από τον γενικό πληθυσμό της Ελβετίας. Οι συγγραφείς βρίσκουν αποτελέσματα που δε συμφωνούν με τα παραπάνω. Φαίνεται ότι οι γονείς παιδιών που έχουν επιβιώσει από καρκίνο παρουσιάζουν τα ίδια επίπεδα μετατραυματικού στρες, με αυτά που παρουσιάζουν οι γονείς στον γενικό πληθυσμό της Ελβετίας. Η μόνη μεταβλητή που σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα μετατραυματικού στρες φαίνεται να είναι το μορφωτικό επίπεδο. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι αυτό ίσως οφείλεται στο ότι οι γονείς με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, με

εργαλεία όπως οι στρατηγικές επίλυσης προβλήματος και περισσότερες πηγές κοινωνικής υποστήριξης (π.χ. ψυχοθεραπεία ή φαρμακοθεραπεία). Τέλος, βρίσκουν επίσης ότι οι μητέρες εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα ενόχλησης και υπερδιέγερσης, σε σχέση με τους πατέρες, γεγονός που ίσως οφείλεται στο ότι οι μητέρες στην Ελβετία αποτελούν τον πρωταρχικό φροντιστή για τα παιδιά και άρα επωμίζονται και περισσότερες συνέπειες από αυτό (Baenziger *et al.*, 2024).

Στη παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουν συμπεριληφθεί 2 μελέτες που σχετίζονται με τα αδέρφια έφηβων και νέων ενήλικων ασθενών με καρκίνο, οι οποίες συμφωνούν εν πολλοίς στα αποτελέσματά τους. Η παλαιότερη εξ' αυτών, η μελέτη των McDonald και συνεργατών (2015) είναι μια συσχετιστική μελέτη με δείγμα 106 εφήβων, με αδερφό ή αδερφή που έχει διαγνωστεί με οποιαδήποτε μορφή καρκίνου, τα τελευταία 5 χρόνια. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχαν κάποιο αδερφό – ασθενή που ήταν παράλληλα σε θεραπεία, ενώ ακολουθούσαν αυτοί που είχαν αδερφό – ασθενή με ολοκληρωμένη θεραπεία. Κατά τους συγγραφείς, τα στοιχεία που καθιστούν τα αδέρφια ΑYA ασθενών με καρκίνο πιο ευάλωτα σε ψυχολογικό βάρος και ανεκπλήρωτες ανάγκες, είναι οι περίοδοι κατά τη θεραπεία ή σε μια υποτροπή (McDonald *et al.*, 2015).

Παράλληλα, στη πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Reuvers και συνεργατών (2023) παρουσιάζονται αντίστοιχα αποτελέσματα. Εν προκειμένω, οι συγγραφείς μελετούν τις ανάγκες και το ψυχολογικό φορτίο των φροντιστών ΑYA ασθενών με καρκίνο. Αναφορικά με τα αδέρφια έφηβων και νέων ενήλικων ασθενών, φαίνεται ότι τα ίδια αναφέρουν μία αίσθηση μοναξιάς κατά τη διάρκεια των θεραπειών, ενώ παράλληλα αποφεύγουν να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους (για παραπάνω προσοχή από τους γονείς) και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους στο γονείς, προκειμένου να μην επιβαρύνουν τη κατάσταση τους (Reuvers *et al.*, 2023).

5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στη παρούσα εργασία είχε υποτεθεί ότι η ψυχική υγεία ή και η ποιότητα ζωής των έφηβων και νέων ενήλικων ασθενών με καρκίνο θα είναι επιβαρυνμένη, σε σχέση με τους υγιείς συνομηλίκους τους (Υπόθεση 1). Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να υιοθετηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποτελέσματα. Δηλαδή, 3 από

τις συμπεριληφθείσες μελέτες παρουσιάζουν ενισχυτικά ως προς την υπόθεση αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Osmani και οι συνεργάτες του (2023) βρίσκουν έναν επιπολασμό της τάξεως του 32%, 29% και 24% σε ψυχολογική επιβάρυνση, άγχος και κατάθλιψη, αντίστοιχα, για ΑΥΑs επιζώντες από καρκίνο. Τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που ισχύουν στον υγιή πληθυσμό μεταξύ 15-39 ετών, τα οποία είναι 4% επιπολασμό για κατάθλιψη και 5% για αγχώδεις διαταραχές (Osmani *et al.*, 2023). Επίσης επιβεβαιωτικά για την υπόθεση 1 αποτελέσματα έχει και η συστηματική ανασκόπηση των Tanner και συνεργατών (2023). Ειδικότερα, αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των ερευνών που μελετούν καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η ψυχική υγεία των ΑΥΑ ασθενών με καρκίνο είναι χειρότερη από αυτή των υγιών συνομηλίκων τους. Οι ίδιοι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια περίοδος ευαλωτότητας για τη ψυχική υγεία των ΑΥΑ επιζώντων από καρκίνο, στην αρχή της πρώτης ενήλικης ζωής τους, η οποία όμως δε συνεχίζεται απαραίτητα, καθώς τα χρόνια περνούν (Tanner *et al.*, 2023). Παράλληλα, εν μέρει ενισχυτικά είναι και τα αποτελέσματα των Wang και συνεργατών (2023) στη δευτερογενή ανάλυσή τους. Σκιαγραφούν, δηλαδή, το προφίλ των εφήβων και νέων ενηλίκων που είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για έκπτωση της ποιότητας ζωής τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η διάγνωση μιας χρόνιας ασθένειας – όπως ο καρκίνος-, ο πόνος (ο οποίος υπάρχει σε πολλές μορφές καρκίνου), καθώς και η φαρμακευτική αγωγή είναι οι παράγοντες κινδύνου για χειρότερη ποιότητα ζωής. Το προφίλ με τα παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνεται ότι σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα θυμού, άγχους, κατάθλιψης και κόπωσης για τους έφηβους και νέους ενήλικες (Wang *et al.*, 2023).

Η δεύτερη υπόθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ότι οι οικείοι/φροντιστές των ΑΥΑ ασθενών με καρκίνο θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη ψυχική υγεία ή και ποιότητα ζωής τους (Υπόθεση 2). Η συγκεκριμένη υπόθεση υιοθετείται σε ένα βαθμό, έχοντας όμως ορισμένες επιφυλάξεις, λόγω της συνθετότητας των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφίας. Σε ό,τι αφορά τους γονείς των ΑΥΑ ασθενών με καρκίνο, τα αποτελέσματα είναι μικτά. Αναλύοντας τις μελέτες με χρονολογική σειρά, φαίνεται ότι σε συστηματική ανασκόπηση του 2016 (Choi *et al.*, 2016), το 51% των φροντιστών των παιδιών με καρκίνο, πληρούν τα κριτήρια για κατάθλιψη κατά τη διάρκεια των θεραπειών των παιδιών τους. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τον επιπολασμό της κατάθλιψης στον γενικό πληθυσμό. Ενώ

προχωρώντας σε μετα-ανάλυση του 2019, βρίσκονται επίσης υψηλά επίπεδα Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (ΔΜΣ), σε γονείς ΑYA ασθενών. Συγκεκριμένα, το 19% των γονέων με έφηβο καρκινοπαθή πληρούσαν τα κριτήρια για τη ΔΜΣ, ποσοστό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ισχύει για τον επιπολασμό της ΔΜΣ στον γενικό πληθυσμό (Pinquart, 2019).

Το τοπίο θολώνει όταν τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης συγχρονικής μελέτης δεν επιβεβαιώνουν χειρότερη ψυχική υγεία των γονέων με έφηβο ή νέο ενήλικα καρκινοπαθή. Αντιθέτως, οι Baezinger και συνεργάτες (2024) υπογραμμίζουν ότι 24 χρόνια (κατά μέσο όρο) μετά από τη διάγνωση, οι γονείς ΑYA επιζώντων από καρκίνο παρουσιάζουν ίδια ή και λιγότερα συμπτώματα μετατραυματικού στρες, σε σύγκριση με γονείς υγιών συνομηλίκων (Baenziger *et al.*, 2024).

Η τελευταία υπόθεση της παρούσας μελέτης είναι ότι η κοινωνική υποστήριξη θα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τη ψυχική υγεία, τόσο των ίδιων των ΑYA ασθενών με καρκίνο, όσο και των οικείων/φροντιστών τους (Υπόθεση 3). Η εικόνα εδώ φαίνεται να είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Η πλειοψηφία των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη παρούσα ανασκόπηση συμφωνούν στον ευεργετικό ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης στη ψυχική υγεία των ασθενών, αλλά και των οικείων τους.

Στη ανάλυση διαδρομών των Liu και συνεργατών (2021) μελετήθηκε η επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης, αυτό-αποτελεσματικότητας και στρατηγικών διαχείρισης της ασθένειας στο ψυχολογικό βάρος που έχουν παιδιά με κακοήθεις όγκους. Εκεί βρέθηκε άμεση, αρνητική συσχέτιση του ψυχολογικού στρες με τη κοινωνική υποστήριξη, σε μέτριο βαθμό (-0.371). Ενώ παράλληλα, η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται ότι μπορεί να επιδράσει με ευεργετικό τρόπο στο ψυχολογικό στρες σε έφηβους ασθενείς με καρκίνο, μέσω της αυτό-αποτελεσματικότητας και των στρατηγικών διαχείρισης της ασθένειας. Φαίνεται, δηλαδή, ότι ένας έφηβος με καρκίνο που έχει αρκετή κοινωνική υποστήριξη, τείνει να έχει υψηλότερα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας, αλλά και να επιλέγει τις πιο προσαρμοστικές στρατηγικές διαχείρισης της ασθένειας, οι οποίες και οδηγούν σε μείωση του ψυχολογικού στρες που βιώνουν (Liu *et al.*, 2021). Επιβεβαιωτικά, επίσης, αποτελέσματα έχει και η μετα-ανάλυση των Osmani και συνεργατών (2023), οι οποίοι καταλήγουν στο ότι οι ΑYA επιζώντες από καρκίνο, χωρίς σύντροφο, αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής επιβάρυνσης και κατάθλιψης, σε σύγκριση με τους παντρεμένους ομόλογούς τους.

Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι κοινωνικές σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν βοηθητικό παράγοντα για τους επιζώντες με διάφορους τρόπους (π.χ. συναισθηματικά, οικονομικά κ.α.).

Ο ίδιος ευεργετικός ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης στη ψυχική υγεία φαίνεται να ισχύει και στη περίπτωση των οικείων/φροντιστών ΑΥΑ ασθενών με καρκίνο. Διαπιστώνεται ότι οι γονείς που είχαν υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης, ανέφεραν και χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής δυσφορίας. Ενώ, φαίνεται πως η σχέση αυτή λειτουργεί και αντιστρόφως. Δηλαδή, ότι η προστατευτική αυτή δράση της αντιλαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης δε λειτουργεί επαρκώς στους ήδη καταθλιπτικούς φροντιστές. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι φροντιστές που έχουν ήδη εκδηλώσει κατάθλιψη δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τις εξωτερικές πηγές κοινωνικής υποστήριξης που τους προσφέρονται, μειώνοντας έτσι τη προστατευτική της δράση επί της ψυχικής δυσφορίας τους (Choi *et al.*, 2016). Σε αντίστοιχα αποτελέσματα φτάνει και άλλη, πιο πρόσφατη μετα-ανάλυσή, στην οποία βρίσκεται μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ των διαθέσιμων πηγών κοινωνικής υποστήριξης και της ανάπτυξης γονεϊκών συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες. Με λίγα λόγια, φαίνεται ότι το να έχεις κάποιο σύντροφο και διαθέσιμη κοινωνική υποστήριξη λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας για την εμφάνιση ΔΜΣ ή/και το αντίστροφο. Δηλαδή, ότι η εμφάνιση συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες στους γονείς έφηβων με καρκίνο σχετίζεται με χειρότερη αλληλεπίδραση αυτών με συγγενείς, φίλους και άλλες πηγές κοινωνικής υποστήριξης (Pinquart, 2019).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα διπλωματική διατριβή αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που μελετά τη ψυχική υγεία των έφηβων και νεαρών ενηλίκων με καρκίνο και των οικείων/φροντιστών τους, σε συνδυασμό με το ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης. Παρά την εκτεταμένη έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία, οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν για περαιτέρω ανάλυση είναι λίγες. Και αυτό διότι, φαίνεται ότι η

έρευνα προσανατολίζεται πολύ περισσότερο στη παιδική και ενήλικη ζωή, αφήνοντας έτσι την ηλικιακή ομάδα των εφήβων και νέων ενηλίκων εν πολλοίς ανεξερεύνητη.

Παράλληλα, η έλλειψη δεδομένων από ελληνικές μελέτες δημιουργεί ένα πρόβλημα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. Δηλαδή, τα όποια συμπεράσματα εξάγονται από τη παρούσα μελέτη είναι επισφαλές να γενικευθούν στην εγχώρια πραγματικότητα, καθώς κάτι τέτοιο –ελλείψει ελληνικών ερευνών- θα ήταν αυθαίρετο και ανακριβές. Τα συμπεράσματα, λοιπόν, της παρούσας διπλωματικής διατριβής άπτονται της διεθνούς εικόνας και όχι ειδικά στα ελληνικά δεδομένα.

Επίσης, ενώ έγινε προσπάθεια για την επιλογή των καταλληλότερων και επαρκέστερων μελετών, κάποιες από αυτές δεν ήταν πρωτογενείς μελέτες και επομένως η βαρύτητά των αποτελεσμάτων τους, είναι μικρότερη.

6.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αναφορικά με τους ίδιους τους AYAs ασθενείς, φαίνεται ότι πράγματι η ψυχική υγεία αυτών παρουσιάζει εκπτώσεις. Ειδικά στους επιζώντες από καρκίνο AYAs ασθενείς (δηλαδή όχι αυτούς που είναι σε θεραπεία), τα αποτελέσματα συμφωνούν και καταδεικνύουν ανεβασμένα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης, σε σύγκριση με τον γενικό, συνομήλικο πληθυσμό (Osmani *et al.*, 2023). Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν και παλαιότερες έρευνες. Μία μεγάλη μερίδα AYAs επιζώντων από καρκίνο αναφέρουν πτωχότερη σωματική και ψυχική υγεία, σε σχέση με συνομηλίκους που δεν είχαν ιστορικό καρκίνου (Tai *et al.*, 2017).

Ενώ, σημαντικό ρόλο για τους AYAs επιζώντες από καρκίνο, φαίνεται να παίζουν και οι μεταγνωστικές πεποιθήσεις για την υγεία τους. Η μεταγνώση αναφέρεται σε ένα σύνολο στρατηγικών, γνώσεων και διεργασιών που αξιολογούν, παρακολουθούν και ελέγχουν τη σκέψη (Tajrishi, Mohammadkhani and Jadidi, 2011). Το μοντέλο S-REF (Self-Regulatory Executive Function) υποστηρίζει ότι η συναισθηματική δυσφορία γίνεται επίμονη όταν οι αποθηκευμένες μεταγνωστικές πεποιθήσεις κατευθύνουν το άτομο να ανταποκρίνεται με συγκεκριμένο τρόπο σε συνήθεις αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα. Αυτός ο τρόπος αντίδρασης ονομάζεται «Σύνδρομο Γνωστικής Προσοχής» (CAS) περιλαμβάνει: επίμονη σκέψη

(ανησυχία, υπερανάλυση), παρακολούθηση απειλής (εστίαση σε σκέψεις και αισθήσεις) και δυσλειτουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης (αποφυγή, αναζήτηση διαβεβαιώσεων, καταστολή σκέψεων). Οι μεταγνωστικές πεποιθήσεις συνδέονται με τη συναισθηματική δυσφορία και το μετατραυματικό στρες, εξηγώντας το 50% και 41% της διακύμανσής τους αντίστοιχα, ενώ οι αρνητικές μεταγνωστικές πεποιθήσεις είχαν τη μεγαλύτερη συσχέτιση (Fisher *et al.*, 2018).

Από την άλλη οι οικείοι/φροντιστές των ΑYA ασθενών με καρκίνο φαίνεται να παρουσιάζουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Υπάρχουν μελέτες που βρίσκουν μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης και διαταραχής μετατραυματικού στρες σε γονείς με έφηβο ή νέο ενήλικα καρκινοπαθή (Choi *et al.*, 2016; Pinquart, 2019). Ενώ μία μελέτη από τις συμπεριληφθείσες στη παρούσα ανασκόπηση, αναφέρει ίδια ή και λιγότερα συμπτώματα μετατραυματικού στρες σε γονείς ΑYA επιζώντων από καρκίνο (Baenziger *et al.*, 2024).

Η εξήγηση γύρω από τα παραπάνω αντικρουόμενα στοιχεία, ίσως βρίσκεται στην έννοια της «μετατραυματικής ανάπτυξης». Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μία θετική ψυχολογική αλλαγή που επέρχεται ως αποτέλεσμα της πάλης σε εξαιρετικά δύσκολες, ψυχοπιεστικές καταστάσεις, όπως το βίωμα του καρκίνου (Tedeschi, Calhoun and Charlotte, 2004). Συγκεκριμένα, η μετατραυματική ανάπτυξη αξιολογείται με βάση θετικές αλλαγές στον εαυτό, στη σχέση με τους άλλους και στα σχέδια για το μέλλον. Όπως επιβεβαιώνεται και σε παλαιότερη έρευνα, έφηβοι επιζώντες από καρκίνο και οι γονείς τους αναφέρουν θετικές αλλαγές στον τομέα των πλάνων για το μέλλον, αλλά και στην αντίληψη γύρω από την αλληλεπίδραση με τους γύρω τους (Barakat, Alderfer and Kazak, 2006). Ενώ, και σε πιο πρόσφατη έρευνα των Phipps και συνεργατών (2014) σε γονείς παιδιών με καρκίνο, βρίσκονται παρόμοια ποσοστά ΔΜΣ, σε σχέση με γονείς υγιών παιδιών, παρά το ότι οι ίδιοι αναφέρουν τη διάγνωση του παιδιού τους, ως τη πιο τραυματική εμπειρία που έχουν βιώσει ποτέ. Μάλιστα, οι ίδιοι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι, η ψυχική υγεία των γονέων παιδιών με καρκίνο είναι μια δυναμική διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από το χρόνο που περνάει μετά τη διάγνωση. Δηλαδή, ότι η ευαλωτότητα για ανάπτυξη συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες διαρκεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη διάγνωση, το οποίο σταδιακά μειώνεται (Phipps *et al.*, 2014).

Η εικόνα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε ο,τι έχει να κάνει με την κοινωνική υποστήριξη και το ρόλο αυτής στη ψυχική υγεία, τόσο των ΑYA ασθενών, όσο και των οικείων τους. Όλες οι συμπεριληφθείσες στη παρούσα διπλωματική ανασκόπηση έρευνες συμφωνούν στον ευεργετικό της ρόλο, είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο. Στην ίδια εικόνα συνηγορούν και παλαιότερες έρευνες. Ήδη από τη δεκαετία του '90, ο Kazak και οι συνεργάτες του (1997), βρίσκουν ότι η υψηλή αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη σε γονείς επιζώντων από παιδική λευχαιμία, σχετίζεται με λιγότερα συμπτώματα μετατραυματικού στρες, τόσο στις μητέρες, όσο και στους πατέρες (Kazak *et al.*, 1997).

Υποστηρικτικά δεδομένα υπάρχουν και για το ρόλο της κοινωνικής υποστήριξης στους ίδιους του έφηβους και νέους ενήλικες καρκινοπαθείς. Φαίνεται ότι η αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη από οικογένεια, φίλους και ιατρικό προσωπικό είναι ένας σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για τη ψυχική υγεία των ΑYA ασθενών, ασχέτως ηλικίας ή φύλου (Corey *et al.*, 2008). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σημασία των φίλων/συνομηλίκων, ως πηγή κοινωνικής υποστήριξης. Φαίνεται ότι η υποστήριξη που προέρχεται από τους συνομηλίκους σχετίζεται με θετικό συναίσθημα, υπό την έννοια ότι η στήριξη αυτή καλλιεργεί ένα αίσθημα «φυσιολογικότητας» στους έφηβους ασθενείς. Η σχέση αυτή φαίνεται να λειτουργεί και αντίστροφα, δηλαδή ότι όσο περισσότερα θετικά συναισθήματα βιώνουν οι έφηβοι καρκινοπαθείς, τόσο πιο πρόθυμοι είναι να εμπλακούν με συνομηλίκους (Wesley, Zelikovsky and Schwartz, 2013). Παράλληλα, η αίσθηση της «κοντινότητας» σε μια φιλική σχέση, φαίνεται να επιδρά θετικά στους έφηβους καρκινοπαθείς, μειώνοντας το ψυχολογικό τους βάρος, μέσω του μοιράσματος και της κατανόησης που βιώνει ο ασθενής σε μία τέτοια σχέση (Tillery *et al.*, 2017).

6.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση καταλήγει στο ότι η ψυχική υγεία των έφηβων και νέων ενήλικων καρκινοπαθών δέχεται προκλήσεις, τόσο κατά τη περίοδο της διάγνωσης, όσο και μετά από αυτήν. Αυτό που δεν είναι ίσως τόσο ξεκάθαρο είναι εάν αυτό το διάστημα της ψυχικής ευαλωτότητας είναι προσωρινό και διαρκεί βραχυπρόθεσμα μετά τη διάγνωση ή εάν πρόκειται για ένα στάδιο με μακροχρόνια διάρκεια. Εδώ, θα θέλαμε η παρούσα μελέτη να αποτελέσει αφορμή για επόμενες

πρωτογενείς μελέτες που θα ερευνούν ακριβώς αυτό το διάστημα της ψυχικής ευαλωτότητας των ΑΥΑ ασθενών με καρκίνο και συγκεκριμένα τη διάρκεια, αλλά και τους παράγοντες από τους οποίους μπορεί να επηρεαστεί.

Όπως ξεκάθαρα φαίνεται από τη παρούσα διπλωματική εργασία, η κοινωνική υποστήριξη λειτουργεί ευεργετικά στη ψυχική υγεία τόσο των ίδιων των έφηβων και νέων ενήλικων καρκινοπαθών, όσο και για τους οικείους/φροντιστές τους. Ελπίζουμε η παρούσα έρευνα να συμβάλει στην ήδη υπάρχουσα θέση της επιστημονικής κοινότητας επ' αυτού. Ως εκ τούτου, σε κλινικό πια επίπεδο να βοηθήσει στην διαμόρφωση κατάλληλων πρακτικών, αλλά και χώρων, όπου οι ΑΥΑ ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη από την οικογένεια, τους συνομηλίκους και το ιατρικό προσωπικό.

Τέλος, και με δεδομένο ότι η εικόνα για τη ψυχική υγεία των οικείων/φροντιστών των ΑΥΑ ασθενών με καρκίνο δεν είναι ξεκάθαρη, ελπίζουμε ότι η παρούσα ανασκόπηση θα οδηγήσει σε νέες έρευνες που θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Baenziger, J. *et al.* (2024) 'Post-traumatic growth in parents of long-term childhood cancer survivors compared to the general population: A report from the Swiss childhood cancer survivor study—Parents', *Psycho-Oncology*, 33(1). doi: 10.1002/pon.6246.
2. Barakat, L. P., Alderfer, M. A. and Kazak, A. E. (2006) 'Posttraumatic growth in adolescent survivors of cancer and their mothers and fathers', *Journal of Pediatric Psychology*, pp. 413–419. doi: 10.1093/jpepsy/jsj058.
3. Choi, E. K. *et al.* (2016) 'Depression and distress in caregivers of children with brain tumors undergoing treatment: Psychosocial factors as moderators', *Psycho-Oncology*, 25(5), pp. 544–550. doi: 10.1002/PON.3962.
4. Corey, A. L. *et al.* (2008) 'Social support and symptom distress in adolescents/young adults with cancer', *Journal of Pediatric Oncology Nursing*, 25(5), pp. 275–284. doi: 10.1177/1043454208321117.
5. D'Agostino, N. M., Penney, A. and Zebrack, B. (2011) 'Providing developmentally appropriate psychosocial care to adolescent and young adult cancer survivors', *Cancer*, 117(SUPPL. 10), pp. 2329–2334. doi: 10.1002/cncr.26043.
6. Dyba, T. *et al.* (2021) 'The European cancer burden in 2020: Incidence and mortality estimates for 40 countries and 25 major cancers', *European Journal of Cancer*, 157, pp. 308–347. doi: 10.1016/j.ejca.2021.07.039.
7. Fisher, P. L. *et al.* (2018) 'The association of metacognitive beliefs with emotional distress and trauma symptoms in adolescent and young adult survivors of cancer', *Journal of Psychosocial Oncology*, 36(5), pp. 545–556. doi: 10.1080/07347332.2018.1440276.
8. Harper, A. *et al.* (2023) 'Symptom severity and trajectories among adolescent and young adult patients with cancer', *JNCI Cancer Spectrum*, 7(6). doi: 10.1093/jncics/pkad049.
9. Haugan, G. and Eriksson, M. (2021) *Health promotion in health care - Vital theories and research*, *Health Promotion in Health Care - Vital Theories and Research*. doi: 10.1007/978-3-030-63135-2.
10. Kazak, A. E. *et al.* (1997) 'Posttraumatic stress, family functioning, and social

- support in survivors of childhood leukemia and their mothers and fathers’, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 65(1), pp. 120–129. doi: 10.1037/0022-006X.65.1.120.
11. Kazak, A. E. *et al.* (2010) ‘Psychological Outcomes and Health Beliefs in Adolescent and Young Adult Survivors of Childhood Cancer and Controls’, 28(12), pp. 0–5. doi: 10.1200/JCO.2009.25.9564.
 12. Knecht, C., Hellmers, C. and Metzging, S. (2015) ‘The perspective of siblings of children with chronic illness. A literature review’, *Journal of Pediatric Nursing*, 30(1), pp. 102–116. doi: 10.1016/j.pedn.2014.10.010.
 13. Lakey, Brian; Cohen, S. (2000) ‘Social Support Theory and Measurement - Bandura 2000.pdf’.
 14. Liu, Q. *et al.* (2021) ‘Path analysis of the effects of social support, selfefficacy, and coping style on psychological stress in children with malignant tumor during treatment’, *Medicine (United States)*, 99(43). doi: 10.1097/MD.0000000000002288.
 15. di Lonardo, A., Nasi, S. and Pulciani, S. (2015) ‘Cancer: We should not forget the past’, *Journal of Cancer*, 6(1), pp. 29–39. doi: 10.7150/jca.10336.
 16. Magni, G. *et al.* (1988) ‘An integrated approach to the assessment of family adjustment to acute lymphocytic leukemia in children’, *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 78(5), pp. 639–642. doi: 10.1111/j.1600-0447.1988.tb06398.x.
 17. McDonald, F. E. J. *et al.* (2015) ‘Predictors of unmet needs and psychological distress in adolescent and young adult siblings of people diagnosed with cancer’, *Psycho-Oncology*, 24(3), pp. 333–340. doi: 10.1002/pon.3653.
 18. Melguizo-Garín, A. *et al.* (2022) ‘Relation Between Social Support Received and Provided by Parents of Children, Adolescents and Young Adults With Cancer and Stress Levels and Life and Family Satisfaction’, *Frontiers in psychology*, 13. doi: 10.3389/FPSYG.2022.728733.
 19. Nass, S. J. and Patlak, M. (2014) ‘Identifying and addressing the needs of adolescents and young adults with cancer: Workshop summary’, *Identifying and Addressing the Needs of Adolescents and Young Adults with Cancer: Workshop Summary*, pp. 1–77. doi: 10.17226/18547.
 20. National Cancer Institute (2022) ‘What is Cancer ? Differences Between Cancer Cells And Normal Cells How Does Cancer Develop ?’, *Www.Cancer.Gov*, pp. 1–8. Available at: <https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what->

is-cancer.

21. National Cancer Institute (2023) 'Emotional Support for Young People with Cancer - National Cancer Institute', pp. 1–5. Available at: <https://www.cancer.gov/types/aya/support>.
22. National Cancer Institute (2024) 'Common Cancer Types', *Www.Cancer.Gov*, pp. 5–6.
23. National Cancer Intitute (2023) 'Adolescents and Young Adults with Cancer Types of cancer in adolescents and young adults (AYAs)', *Www.Cancer.Gov*, pp. 1–10. Available at: <https://www.cancer.gov/types/aya>.
24. Osmani, V. *et al.* (2023) 'Prevalence and risk of psychological distress, anxiety and depression in adolescent and young adult (AYA) cancer survivors: A systematic review and meta-analysis', *Cancer Medicine*, 12(17), pp. 18354–18367. doi: 10.1002/cam4.6435.
25. Pai, A. L. H. *et al.* (2007) 'A Meta-Analytic Review of the Influence of Pediatric Cancer on Parent and Family Functioning', *Journal of Family Psychology*, 21(3), pp. 407–415. doi: 10.1037/0893-3200.21.3.407.
26. Park, E. M. and Rosenstein, D. L. (2015) 'Depression in adolescents and young adults with cancer', *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 17(2), pp. 171–180. doi: 10.31887/dcns.2015.17.2/epark.
27. Patterson, P., Medlow, S. and McDonald, F. E. J. (2015) 'Recent developments in supporting adolescent and young adult siblings of cancer patients', *Current Opinion in Oncology*, 27(4), pp. 311–315. doi: 10.1097/CCO.0000000000000194.
28. Phipps, S. *et al.* (2014) 'Parents of children with cancer: At-risk or resilient?', *Journal of Pediatric Psychology*, 40(9), pp. 914–925. doi: 10.1093/jpepsy/jsv047.
29. Pinquart, M. (2019) 'Posttraumatic Stress Symptoms and Disorders in Parents of Children and Adolescents With Chronic Physical Illnesses: A Meta-Analysis', *Journal of Traumatic Stress*, 32(1), pp. 88–96. doi: 10.1002/jts.22354.
30. Pizzoli, S. F. M. *et al.* (2019) 'From life-threatening to chronic disease: Is this the case of cancers? A systematic review', *Cogent Psychology*, 6(1), pp. 1–17. doi: 10.1080/23311908.2019.1577593.
31. Reuvers, M. J. P. *et al.* (2023) 'Caring for Adolescents and Young Adults

- (AYA) with Cancer: A Scoping Review into Caregiver Burdens and Needs’, *Cancers*, 15(12), pp. 1–24. doi: 10.3390/cancers15123263.
32. Ritchie, M. A. (2001) ‘Sources of emotional support for adolescents with cancer’, *Journal of Pediatric Oncology Nursing*, 18(3), pp. 105–110. doi: 10.1053/jpon.2001.23600.
 33. Santos, T. *et al.* (2019) ‘(Health-related) quality of life and psychosocial factors in adolescents with chronic disease: A systematic literature review’, *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 31(4), pp. 1–24. doi: 10.1515/ijamh-2017-0037.
 34. SEER. (n.d.). *Cancer Among Adolescents and Young Adults (AYAs) - Cancer Stat Facts*. [online]
 35. Silver, E. J. and Frohlinger-Graham, M. J. (2000) ‘Brief report: Psychological symptoms in healthy female siblings of adolescents with and without chronic conditions’, *Journal of Pediatric Psychology*, 25(4), pp. 279–284. doi: 10.1093/jpepsy/25.4.279.
 36. Speechley, K. N. and Noh, S. (1992) ‘Surviving childhood cancer, social support, and parents’ psychological adjustment’, *Journal of Pediatric Psychology*, 17(1), pp. 15–31. doi: 10.1093/jpepsy/17.1.15.
 37. Steinberg, D. M. *et al.* (2020) “‘It Made Me the Person I Am Today...’: Survivors of Childhood, Adolescent, and Young Adult Cancer Reflect on Their Experiences’, *Journal of Adolescent and Young Adult Oncology*, 9(2), pp. 239–246. doi: 10.1089/jayao.2019.0122.
 38. Tai, E. *et al.* (2017) ‘Health Status of Adolescent and Young Adult Cancer Survivors’, 118(19), pp. 4884–4891. doi: 10.1002/cncr.27445.Health.
 39. Tajrishi, K. Z., Mohammadkhani, S. and Jadidi, F. (2011) ‘Metacognitive beliefs and negative emotions’, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 30, pp. 530–533. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.10.103.
 40. Tanner, S. *et al.* (2023) ‘Mental health patient-reported outcomes among adolescents and young adult cancer survivors: A systematic review’, *Cancer Medicine*, 12(17), pp. 18381–18393. doi: 10.1002/cam4.6444.
 41. Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. and Charlotte, C. (2004) ‘Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence’, 15(January 2004), pp. 1–18. doi: 10.1207/s15327965pli1501.

42. Tillery, R. *et al.* (2017) 'Youth's Adjustment to Cancer: Examination of Patterns of Adjustment and the Role of Peer Relations', *Journal of Pediatric Psychology*, 42(10), pp. 1123–1132. doi: 10.1093/jpepsy/jsx067.
43. Trama, A. *et al.* (2023) 'Cancer burden in adolescents and young adults in Europe', *ESMO Open*, 8(1). doi: 10.1016/j.esmoop.2022.100744.
44. Wang, S. *et al.* (2023) 'Health-related quality of life profiles in adolescents and young adults with chronic conditions', *Quality of Life Research*, 32(11), pp. 3171–3183. doi: 10.1007/s11136-023-03463-5.
45. Wesley, K. M., Zelikovsky, N. and Schwartz, L. A. (2013) 'Physical symptoms, perceived social support, and affect in adolescents with cancer', *Journal of Psychosocial Oncology*, 31(4), pp. 451–467. doi: 10.1080/07347332.2013.798761.
46. World Health Organization (2022). *COVID-19 Pandemic Triggers 25% Increase in Prevalence of Anxiety and Depression Worldwide*. [online] World Health Organization
47. Yin, S. *et al.* (2016) 'Summarizing health-related quality of life (HRQOL): Development and testing of a one-factor model', *Population Health Metrics*, 14(1), pp. 1–9. doi: 10.1186/s12963-016-0091-3.
48. Zebrack, B., Chesler, M. A. and Kaplan, S. (2010) 'To foster healing among adolescents and young adults with cancer: What helps? What hurts?', *Supportive Care in Cancer*, 18(1), pp. 131–135. doi: 10.1007/s00520-009-0719-y.